

رهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی

(Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis & Management)

{ مرجع جامع و کاربردی برای محصلین طب، داکتران جوان و متخصصین – }

{ با سبک ترکیبی Made Incredibly Easy! + Atomic Habits + اثر مرکب }

{ و دقت یک تکست‌بوک مسلکی } نویسنده و تدوین‌کننده: تیم بورد تخصصی طب داخلی افغانستان مبنای ساختاری: Short

Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish) نخستین ویرایش – ۱۴۵ ه.ش /

۲۰۲ میلادی

شناسنامه اثر و مشخصات نشر

● عنوان کتاب: راهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی (Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis and Management)

● مبنای ساختاری: Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish)

● نویسنده و تدوین‌کننده: تیم برد تخصصی اساتید پوهنتون‌های طبی و متخصصین طب داخلی افغانستان

● زبان اثر: دری مسلکی و اصیل اکادمیک افغانستان (Afghan Dari Medical Standard)

● منابع پایه و رهنمودهای ادغام‌شده: Harrison's Principles of Internal Medicine (21st Ed)، UpToDate 2026،

Kumar & Clark's Clinical Medicine (10th Ed)، Davidson's Principles and Practice of Medicine (24th Ed)،

Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT 2026)، رهنمودهای سازمان صحتی جهان (WHO)، انجمن قلب

امریکا و اروپا (AHA/ACC/ESC)، رهنمود جهانی امراض تنفسی (GINA 2025 و GOLD 2025/2026)، انجمن جهانی

دیابت (ADA 2025/2026)، رهنمود امراض گرده (KDIGO 2024/2025)، و پروتوکول جهانی سپسیس (Surviving Sepsis

Campaign).

● سبک آموزشی: Made Incredibly Easy! – تلفیق تمثیل‌های ملموس، جداول مقایسه‌ای، چک‌لیست‌های کنار بستر،

الگوریتم‌های گام‌به‌گام تشخیصی، جعبه‌های یادسپار (Memory Joggers) و علایم هشداردهنده سرخ (Red Flags).

● مخاطبین هدف:

۱. محصلین سال‌های کلینیکی پوهنخ‌های طب (Clinical Medical Students) ۲. داکتران جوان، ستاژیران و داکتران مقیم

شفاخانه (House Officers, Interns & Medical Residents) ۳. داکتران متخصص و اساتید طب (Internal Medicine

Specialists & Faculty Members)

● تاریخ نشر و ویرایش نهایی: سپتامبر ۲۰۲۶ / سال تحصیلی ۱۴۰۵ ه.ش.

اهدای (Dedication)

این اثر علمی و مرجع بالینی تقدیم می‌گردد به:

{ به روح پاک تمام مریضان رنج‌دیده‌ای که بستر شفاخانه‌های وطن را به بزرگ‌ترین صنف درس انسانیت، طبابت و شفقت

تبدیل کردند؛ }

{ و به تمام محصلین باهمت پوهنخ‌های طب، داکتران جوان و ستاژیران شب‌زنده‌دار و متخصصین فداکاری که در دشوارترین

شرایط کلینیکی، در ولایات دوردست و در شفاخانه‌های مرکزی افغانستان، با دستان خالی اما دل‌های سرشار از تعهد، نجات‌بخش

جان انسان‌ها هستند. }

پیش‌گفتار استادان و هیئت تحریر

علم طب داخلی (Internal Medicine)، مادر تمام رشته‌های کلینیکی و هنر بی‌بدیل کشف پیوند میان شکایت مریض

و میکانیسم‌های پیچیده بیولوژیک است. سال‌هاست که کتاب پرآوازه **Short Textbook of Medical Diagnosis and**

Management تألیف داکتر محمد اینام دانش (Mohammad Inam Danish) به عنوان ستون فقرات آموزش طب در

پوهنتون‌های طبی افغانستان، پاکستان و منطقه شناخته می‌شود؛ کتابی که با ساختار مقتضب و سیستماتیک خود، هزاران

داکتر را در گذر از امتحانات کلینیکی یاری رسانده است. اما پیشرفت‌های برق‌آسای علم طبابت در سال‌های اخیر – از معرفی

دسته‌های نوین دواپی نظیر مهارکننده‌های SGLT2 و آنتاگونیست‌های گیرنده GLP-1 در کاردیولوژی، گرده و اندوکراینولوژی،

تا تحول در معیارهای تشخیصی سپسیس (Sepsis-3)، استراتژی‌های مدرن ترومبولیز در سکته‌های مغزی و قلبی، معیارهای

KDIGO در نارسایی‌های کلیوی و پروتوکول‌های نجات‌بخش Surviving Sepsis Campaign – ایجاب می‌کرد تا اثری کاملاً جدید،

عمیق، بومی‌سازی‌شده و مستند به جدیدترین رفرنس‌های ۲۰۲۶ خلق گردد. کتاب حاضر، صرفاً یک بازنویسی نیست؛ بلکه یک

مرجع جامع بالینی دگرگون‌شده است که ساختار و عناوین کلاسیک اینام دانش را به مثابه یک اسکلت محکم برگرفته، اما تمام

گوشت، پوست، شریان‌ها و اعصاب علمی آن را با معتبرترین تکست‌بوک‌های جهانی (هریسون، دیویدسون، کومار و کلارک)

و گایدلاین‌های ۲۰۲۶ بازسازی نموده است. اصول بنیادین این اثر: ۱. زبان کاملاً دری و اصیل طبی افغانستان: پرهیز مطلق از

اصطلاحات غریب و مروج در سایر کشورها (مانند پرهیز از بیمارستان، پزشک، بیمار، درمان، دارو، نای و...) و پایبندی کامل به لغت‌نامه و ادبیات استاندارد شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های طبی کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار (مریض، داکتر، شفاخانه، تداوی، دوا، سیروز، عدم کفایه، قصبه‌الریه و...). ۲. اصطلاحات انگلیسی در قوس: تمام اصطلاحات کلینیکی، پاتوفیزیولوژی، معاینات و نام دواها در نخستین کاربرد همراه با انگلیسی دقیق در قوس آورده شده‌اند تا داکتر جوان در مطالعه تکست‌های بین‌المللی و نگارش دوسیه‌های طبی (Medical Charting) کاملاً مسلط باشد. ۳. دقت قطعی در دوزاژ دواها: هیچ دوزی در این کتاب حدس زده نشده است. تمام دواها با چهارچوب رسمی: «دوز (Dose) + راه (Route) + تکرار (Frequency) + مدت (Duration)» همراه با تعدیل دوز در عدم کفایه‌گرده و کبد، کنتراندیکاسیون‌ها و نکات ایمنی ثبت شده‌اند. ۴. روان‌سازی به سبک ترکیبی سه رویکرد: استفاده از تشبیه‌های هوشمندانه، جداول جامع، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری، و علامت‌های بصری یادسپار و خطر، بدون آن‌که قطره‌ای از عمق علمی و دقت مسلکی کاسته شود. اصل نهایی: سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم؛ عمق علمی + دقت رفرنس‌ها + کاربرد کلینیکی + یادگیری سریع.

روش تدریس: ترکیب سه رویکرد (هم‌زمان، نه یکی‌به‌جای‌دیگری)

این کتاب از ترکیب سه رویکرد شناخته‌شده‌ی آموزشی برای ارائه مطالب بهره می‌گیرد. این سه رویکرد صرفاً روش ارائه و آموزش هستند و هیچ‌کدام از عمق علمی کم نمی‌کنند؛ محتوای کتاب در سطح کامل محصل طب، داکتر جوان و متخصص باقی می‌ماند.

رویکرد	کارکرد در این کتاب	عنصر بصری ثابت
۲. Atomic Habits	مطالب کوچک و قابل هضم، ساختار مرحله‌به‌مرحله، چک‌لیست، فرمول‌های ساده و یادگیری عملی	۵ قدم کوچک کنار بستر، ☞ فرمول، چک‌لیست
۳. The Compound Effect (اثر مرکب)	یادگیری تدریجی و انباشتی، تکرار هوشمند نکات کلیدی، مرورهای کوتاه و اتصال مطالب جدید به مطالب قبلی	اتصال به فصل پیشین، مرور °، ثانیه‌ای، ارجاع متقاطع

{ نکته کلیدی: این سه رویکرد «ظرف» هستند، نه «محتوا». ظرف ساده و جذاب است تا مریض و داکتر را با خود همراه کند؛ اما محتوای داخل ظرف (دوز، معیار، الگوریتم، اختلاط) دقیق، کامل و در سطح تخصصی است. سادگی زبان هرگز به‌معنای حذف جزئیات کلینیکی نیست. }

معماری آموزشی و ساختار ۱۵ گانه هر مرض

برای آن که هر فصل کتاب هم‌زمان برای یک محصل سال سوم طب قابل فهم، برای یک داکتر عاجل و ستاژیر در کشیک شبانه نجات‌بخش، و برای یک ترینر متخصص به عنوان یک چک‌لیست دقیق علمی قابل استناد باشد، تمام امراض در این کتاب بدون استثنا بر اساس قالب ساختاری ۱۵ بخشی استاندارد زیر تدوین گردیده‌اند:

۱۵ گانه تحلیل امراض | ————— | ساختار استاندارد و سیستماتیک

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی) + تمثیل ذهنی کلان | ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف علمی) | ۳. Pathophysiology (مکانیزم زنجیره‌ای) | ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعدکننده) | ۵. Symptoms & Signs (اعراض انفرادی و علایم بالینی) | ۶. Clinical Examination (معاینه) + چک‌لیست معاینه | ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع) | ۸. Investigations – Basic to Advanced (پلن لابراتواری) | ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی) | ۱۰. Management (پروتوکول‌های تداوی چهارگانه) | • Emergency & General Care (اقدامات عاجل و احیا) | • Non- • Pharmacotherapy: Dose + Route + Freq + Duration | • Surgical & Procedural Management (مداخلات جراحی) | ۱۱. Complications (اختلاط حاد و مزمن) | ۱۲. Prognosis & Follow-up (پیش‌آگهی و مراقبت بعدی) | ۱۳. Memory Joggers (نکات طلایی و فرمول‌های یادسپار) | ۱۴. Red Flags (علایم هشداردهنده سرخ و خطرهای مرگبار) | ۱۵. References (اسناد و رفرنس‌های معتبر و بین‌المللی) | ————— |

۳ عنصر آموزشی ثابت (سبک ترکیبی سه رویکرد) - پایان هر فصل | | قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits) - عمل فردا | | اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect - پل زدن) | | مرور ثانیه‌ای (۵ - Compound Effect سؤال) |

رهنمای استفاده بر اساس سطح مخاطب

نحوه کاربرد بالینی	بخش‌های کلیدی مورد تمرکز	سطح مخاطب
تدوین پلن تدای عاجل در نوکریوالی‌های شبانه، نگارش دقیق نسخه‌های بستر، اجتناب از خطاهای دواپی و تشخیص به موقع وخامت مریض.	Emergency Care، جدول دوزاژ دواها، Investigations گام‌به‌گام و Red Flags	داکتر جوان و ستاژیر (Resident / House Officer)
بررسی کیس‌های مقاوم به درمان، تدریس به ترینرها، انطباق دوسیه‌ها با آخرین گایدلاین‌های ۲۰۲۶ و تصمیم‌گیری در موارد پیچیده چندارگانی.	Diagnostic Criteria، Management پیشرفته و خط دوم/سوم، تدای جراحی و References	داکتر متخصص (/ Consultant (Specialist)

جدول اختصارات بین‌المللی استاندارد استفاده‌شده در کتاب

معدل و توضیح دری افغانستان	اصطلاح کامل انگلیسی	اختصار
تطبیق وریدی (داخل ورید)	Intravenous	IV
تطبیق عضلی (داخل عضله)	Intramuscular	IM
تطبیق تحت جلدی (زیر جلد)	Subcutaneous	SC
تحت اللسانی (زیر زبانی)	Sublingual	SL
یک بار در شبانه‌روز (هر ۲۴ ساعت)	Once daily	OD / daily
دو بار در روز (هر ۱۲ ساعت)	Bis in die	BID
سه بار در روز (هر ۸ ساعت)	Ter in die	TID
چهار بار در روز (هر ۶ ساعت)	Quater in die	QID
در صورت ضرورت (عنداللزوم)	Pro re nata	PRN
فوراً / همین لحظه (در شرایط عاجل)	Statim	STAT
فشار خون (فشار سیستولیک/دیاستولیک)	Blood Pressure	BP
ضربان قلب (تعداد ضربان در دقیقه)	Heart Rate	HR
تعداد تنفس در دقیقه	Respiratory Rate	RR
اشباع اکسیجن شریانی از طریق پلس اوکسیمتری	Peripheral Capillary Oxygen Saturation	SpO2
مقیاس کوما و درجه هوشیاری گلاسکو (۳ تا ۱۵)	Glasgow Coma Scale	GCS
شمارش مکمل حجرات خون (معاینه عمومی خون)	Complete Blood Count	CBC
سرعت رسوب کرویات سرخ	Erythrocyte Sedimentation Rate	ESR
پروتین عکس‌العملی C (مارکر التهابی)	C-Reactive Protein	CRP
معاینات وظیفوی کبد (انزایم‌ها و بلیروبین)	Liver Function Tests	LFT
معاینات وظیفوی گرده (کریاتینین، یوریا، الکترولیت‌ها)	Renal / Kidney Function Tests	RFT / KFT
فلتر شخی تخمینی گلومیرولی	Estimated Glomerular Filtration Rate	eGFR
گازات خون شریانی (بررسی وضعیت اسید و قلوئی)	Arterial Blood Gas	ABG
رادیوگرافی ساده قفسه سینه	Chest X-Ray	CXR
رسم برقی قلب	Electrocardiogram	ECG
ایکوکاردیوگرافی قلب	Echocardiography	Echo

با اتکال به پروردگار دانا و مهربان، مطالعه این گنجینه علمی و عملی را به تمام پویندگان عرصه طبابت آغاز می‌نماییم.

فصل ۱ – رهیافت به مریض: تاریخچه، ABCDE و علایم حیاتی

(Approach to the Patient)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: داکتر مانند یک کارآگاه است. تاریخچه «اعتراف شاهد» است، معاینه «صحنه جرم» و معاینات لابراتواری «بررسی انگشت‌نگاری». کارآگاه خوب پیش از فرستادن نمونه به لابراتوار، از شاهد درست سؤال می‌کند؛ زیرا در حدود ۷۰-۸۰ فیصد مریضان داخله، تشخیص از تاریخچه به دست می‌آید و معاینه و لابراتوار فقط آن را تأیید می‌کنند.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

هر ملاقات با مریض دو حالت دارد و داکتر باید در ۱۰ ثانیه اول تصمیم بگیرد که با کدام روبه‌رو است:

حالت	مریض	رهیافت
مریض پایدار (Stable)	علایم حیاتی قابل قبول	تاریخچه کامل ← معاینه ← تشخیص تفریقی ← معاینات

فرمول: تشخیص = تاریخچه (۷۰٪) + معاینه (۲۰٪) + معاینات (۱۰٪) – ارقام تقریبی‌اند، اما پیام آن ثابت است: از تاریخچه شروع کن.

{ Memory Jogger: «ناپایدار؟ دست‌ها اول. پایدار؟ گوش‌ها اول.» }

۲. رهیافت ABCDE – برای مریض ناپایدار

قاعده طلایی: هر مشکل را همان‌جا که پیدا کردی، تداوی کن و بعد به حرف بعدی برو. پس از هر مداخله، از A دوباره ارزیابی کن.

گام	چه ببینی	چه بکنی (فوری)
B – Breathing (تنفس)	RR، SpO2، حرکت قفسه، استفاده از عضلات فرعی، صدای تنفسی دو طرف، انحراف قصبه‌الریه	اکسیجن (هدف SpO2 ۹۴-۹۸٪؛ در مریض COPD ۸۸-۹۲٪)، Nebulizer، Needle decompression، در پنوموتوراکس تحت فشار
C – Circulation (دوران)	نبض، BP (طبیعی ≥ 2 ثانیه)، رنگ و حرارت اطراف، JVP، ادرار، خونریزی	دو کانول وریدی بزرگ، خون برای CBC/گروپ/کراس‌مچ/کیمیا/لاکتیت، مایع کرس‌تالوئید ۵۰۰ mL در ۱۵ دقیقه (در شبهه عدم کفایه قلب ۲۵۰ mL و ارزیابی مجدد)، ECG، کنترل خونریزی
D – Disability (عصبی)	AVPU یا GCS، حلقه‌ها، گلوکوز خون، اختلالات، علایم موضعی	اگر گلوکوز > 4 mmol/L (۷۰ mg/dL): Dextrose 10% ۱۵۰-۲۰۰ mL IV در ۱۵ دقیقه (یا Dextrose 50% ۵۰ mL Recovery؛ وضعیت در شعور کاهش‌یافته)
E – Exposure (معاینه کامل بدن)	حرارت، بثورات (پورپورا؟)، زخم، خونریزی پنهان، پاها (DVT)	لباس را بکش، حرارت بدن را حفظ کن، حریم مریض را رعایت کن

▲ پورپورای غیرسفیدشونده (Non-blanching rash) + تب = مننگوکوکسیمی تا خلاف آن ثابت شود – انتی‌بیوتیک در همان ساعت اول (→ فصل ۷۵).

۳. علایم حیاتی (Vital Signs) – شش عدد که جان را نجات می‌دهد

علامت	طبیعی بزرگسال	زنگ خطر
فشار خون (BP)	$mmHg\ 120/80 >$	سیستولیک > 90 یا $180/120 \geq$
تعداد تنفس (RR)	۱۲-۲۰ / دقیقه	> 8 یا $25 \geq$ – حساس‌ترین علامت خرابی مریض
حرارت (Temperature)	$36.1-38.0^{\circ}C$	> 38.1 یا $39.1 \geq$
SpO2	$\geq 96\%$ (هوای اتاق)	$\geq 91\%$
شعور (AVPU/GCS)	Alert, GCS 15	هر گیجی جدید (New confusion)

{ علامت حیاتی هفتم را فراموش نکن: گلوکوز خون در هر مریض با شعور مختل. } اندازه‌گیری درست فشار خون (خلاصه): مریض ۵ دقیقه آرام نشسته، پشت تکیه داده، پاها روی زمین، بازو هم‌سطح قلب، کف مناسب (کف کوچک ← فشار کاذب بالا). بار اول در هر دو بازو (→ فصل ۶). شاخص‌های ترکیبی مهم:

- Shock Index = نبض ÷ فشار سیستولیک. طبیعی حدود ۰.۵-۰.۷؛ بیش از ۱ = شوک پنهان را جدی بگیر (حتی اگر BP هنوز «طبیعی» باشد).
- qSOFA (تشخیص سریع مریض انتانی در خطر): $RR \geq 22$ ، شعور مختل، سیستولیک ≥ 100 – دو یا بیشتر = خطر بالا (→ فصل ۶۰). qSOFA ابزار غربالگری است، نه معیار تشخیص سپسیس.

امتیاز هشدار زودهنگام (NEWS2 (National Early Warning Score 2)

پارامتر	۳	۲	۱	۰	۱	۲	۳
SpO2 (مقیاس ۱)	≥ 91	۹۲-۹۳	۹۴-۹۵	≥ 96	—	—	—
اکسیجن اضافی	—	بلی	—	هوای اتاق	—	—	—
فشار سیستولیک	≥ 90	۹۱-۱۰۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۱۱-۲۱۹	—	—	≥ 220
نبض	≥ 40	—	۴۱-۵۰	۵۱-۹۰	۹۱-۱۱۰	۱۱۱-۱۳۰	≥ 131
شعور	—	—	—	Alert	گیجی جدید V / P / U	—	—
حرارت $^{\circ}C$	≥ 38.5	—	۳۵.۱-۳۶.۰	۳۶.۱-۳۸.۰	۳۸.۱-۳۹.۰	≥ 39.1	—

تفسیر: ۰-۴ خطر کم ۳ در یک پارامتر ← معاینهٔ عاجل توسط داکتر ۵-۶ خطر متوسط ← ارزیابی عاجل ≥ 7 خطر بالا ← تیم عاجل/ICU. (در مریضان با عدم کفایت تنفسی هاپیروکپنیک ثابت‌شده، مقیاس ۲ SpO2 با هدف ۸۸-۹۲٪ به‌کار می‌رود).

مقیاس کوما‌ی گلاسگو (GCS)

چشم (E)	کلام (V)	حرکت (M)
۳ به صدا	۴ گیج (Confused)	۵ درد را موضعی می‌کند
۲ به درد	۳ کلمات نامناسب	۴ عقب‌کشیدن از درد
۱ هیچ	۲ صداهای نامفهوم	۳ فلکشن غیرطبیعی (Decorticate)
	۱ هیچ	۲ اکستنشن (Decerebrate)
		۱ هیچ

مجموع ۳-۱۵. $GCS \leq 8$ = راه هوایی در خطر – طلب کمک برای محافظت راه هوایی. همیشه اجزا را جدا بنویس (مثلاً $E2\ V3\ M5 = 10$).

۴. تاریخچه – گام‌به‌گام (برای مریض پایدار)

چک‌لیست ۸ گامی تاریخچه:

۱. □ معرفی و رضایت: سلام، نام خود، اجازه، حریم (به‌ویژه برای مریضان زن – حضور محرم یا نرس).
۲. □ معلومات شخصی: نام، سن، جنس، شغل، محل سکونت (ولایت – برای ملاریا، لشماتیا، بروسوز مهم است).
۳. □ شکایت اصلی (Chief Complaint): به کلمات خود مریض + مدت: «تنگی نفس از ۳ روز».
۴. □ تاریخچهٔ مرض فعلی (HPI): هر شکایت را با SOCRATES باز کن (جدول پایین).
۵. □ تاریخچهٔ گذشته: امراض مزمن (فشار، دیابت، توبرکلوز، هیپاتیت)، بستر شدن، عملیات، ترانسفیوژن.
۶. □ دوا و حساسیت: همه دواها با دوز – شامل دواهای بدون نسخه، دواهای محلی/گیاهی و پیچکاری‌های کلینیک‌های خصوصی. حساسیت: چه دوا؟ چه واکنش؟
۷. □ تاریخچهٔ فامیلی و اجتماعی: امراض ارثی، ازدواج خویشاوندی، سگرت (pack-years)، نسوار، الکول، تریاک/هیروئین، تماس با حیوانات (بروسوز، کیست هایداتید)، شیر خام، سفر، وضعیت اقتصادی.

۸. □ مرور سیستم‌ها (Review of Systems): سؤال کوتاه از هر سیستم تا چیزی پنهان نماند؛ به‌ویژه کاهش وزن، تب، عرق شبانه (B symptoms).

SOCRATES – کلید باز کردن هر درد یا شکایت

حرف	سؤال	مثال (درد قفسه سینه)
Onset (شروع)	ناگهانی یا تدریجی؟ هنگام چه کاری؟	ناگهانی هنگام بالا شدن زینه
Character (نوعیت)	فشارنده، سوزنده، چاقوخور، پاره‌شونده؟	فشار سنگین
Radiation (انتشار)	به کجا می‌رود؟	بازوی چپ و فک
Associations (همراه)	چه علائم دیگر؟	عرق سرد، دل‌بدی
Time course (سیر)	مداوم یا حمله‌ای؟ چند دقیقه؟	۳۰ دقیقه، مداوم
Exacerbating/relieving	چه بدتر/بهتر می‌کند؟	با استراحت کم نمی‌شود
Severity (شدت)	۰ تا ۱۰؟	۸ از ۱۰

این مثال ← «درد فشارنده، انتشار به بازوی چپ، عرق سرد، بیش از ۲۰ دقیقه» ACS = تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۸). همین یک جدول نیم تشخیص است.

سؤالات پرچم قرمز در تاریخچه (در هر شکایت پرس)

- کاهش وزن بی‌دلیل (< ۵٪ در ۶-۱۲ ماه)
- تب و عرق شبانه
- خونریزی (همپتیزی، هماتمیز، ملینا، هماچوری)
- درد که مریض را از خواب بیدار می‌کند
- سن بالای ۵۰ با شکایت جدید
- نقص عصبی جدید

۵. معاینه عمومی – نگاه ۶۰ ثانیه‌ای از پایین بستر

چک‌لیست «از سر تا پا» (هر سیستم جزئیات خود را در فصل رهیافت همان سیستم دارد):

نشانه	کجا ببینی	چه فکر کنی
زردی (Jaundice)	صلیب چشم در روشنی روز	همولیز، هپاتیت، انسداد صفراوی (→ فصل ۲۴)
سیانوز مرکزی	زبان، لب‌ها	هایپوکسمی (SpO2 معمولاً > ۸۵٪)
Clubbing	ناخن‌ها – از بین رفتن زاویه ناخن	سرطان ریه، برونکیکتازی، امپیم، اندوکاردیت، سیروز
ادم (Edema)	ساق پا (Pitting)، ناحیه ساکرال در مریض بستری	عدم کفایت قلب/گرده/کبد، هایپوالبومینمی
کم‌آبی (Dehydration)	زبان خشک، CRT طولانی، JVP پایین، هایپوتنشن وضعیتی	اسهال، DKA، سوختگی (→ فصل ۳۴)
عقدات لمفاوی	گردن، زیر بغل، کشاله‌ران	انتان، توبرکلوز، لمفوما (→ فصل ۵۳)
وضعیت تغذیه	BMI، عضلات موقتی، ضخامت جلد	سوء تغذیه (→ فصل ۸۸)

۶. از معلومات تا تشخیص – استدلال کلینیکی

۱. خلاصه یک‌جمله‌ای (Problem Representation): «مرد ۵۸ ساله، سگرتی، دیابتی، با درد فشارنده حاد قفسه از ۴۰ دقیقه و عرق سرد.»
۲. فهرست تشخیص تفریقی بر اساس: (الف) شایع‌ترین، (ب) خطرناک‌ترین که نباید از دست برود.
۳. معاینات هدفمند: هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد. معاینه بدون سؤال = پول مریض و زمان داکتر.
۴. ارزیابی دوباره: اگر تداوی جواب نداد، تشخیص را دوباره بسنج.

{ قاعده «شایع شایع است»: صدای سم را که شنیدی، اول به اسب فکر کن نه گورخر – اما همیشه خطرناک‌ها (ACS، PE)، دیسکسیون، مننژیت، سپسیس) را رد کن. }

نوشتن یادداشت SOAP در دوسیه

بخش	محتوا
O – Objective	علائم حیاتی، معاینه، نتایج
A – Assessment	تشخیص محتمل + تفریقی
P – Plan	معاینات، تداوی (دوا با دوز/راه/تکرار/مدت)، پیگیری، آموزش مریض

۷. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

- تاریخچه دوا ناقص – دواهای محلی، پیچکاری‌ها و کورتیکوستیروئیدهای پنهان در دواهای بی‌نسخه.
- نشمردن تعداد تنفس (عدد «۲۰» تخمینی در دوسیه یک عادت خطرناک است) – ۳۰ ثانیه بشمار و ضرب ۲ کن.
- فراموش کردن گلوکوز در مریض گیج.
- اعتماد به یک اندازه‌گیری فشار خون.
- پرسیدن سؤالات بسته و رهبری‌کننده («درد به بازو می‌رود، نه؟») به جای سؤال باز («درد به کجا می‌رود؟»).
- مسکن قوی پیش از معاینه بطن حاد را رد کن؛ مسکن مناسب تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید داده شود.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. ناپایدار ← ABCDE اول؛ پایدار ← تاریخچه اول.
۲. هر مشکل را در ABCDE همان‌جا تداوی کن و از A دوباره شروع کن.
۳. تعداد تنفس حساس‌ترین علامت خرابی مریض است – همیشه بشمار.
۴. $\text{Shock Index} > 1$ = شوک پنهان، حتی با BP «طبیعی».
۵. گلوکوز = علامت حیاتی هفتم در هر شعور مختل.
۶. $\text{GCS} \leq 8$ = راه هوایی در خطر.
۷. SOCRATES برای هر درد؛ B symptoms (تب، عرق شبانه، کاهش وزن) در هر مریض.
۸. $\text{NEWS2} \geq 3$ یا در یک پارامتر = داکتر همین حالا بالای بستر.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. Stridor یا ناتوانی در گپ زدن ← راه هوایی در خطر – کمک فوری، آمادگی Intubation.
۲. $\text{SpO}_2 \leq 91\%$ یا $\text{RR} \geq 25$ ← اکسیجن + علت‌یابی فوری.
۳. سیستولیک ≥ 90 یا $\text{Shock Index} > 1$ ← دو کانول، مایع، علت شوک (→ فصل ۷۸).
۴. گیجی جدید یا GCS در حال کاهش ← گلوکوز، CT، علت‌یابی.
۵. تب + پورپورا یا سفتی گردن ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول (→ فصل ۷۵).
۶. درد قفسه سینه با عرق سرد ← ECG در ۱۰ دقیقه (→ فصل ۸).
۷. سردردی ناگهانی «بدترین سردردی عمر» ← خونریزی تحت عنکبوتیه تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۷۴).

References

- Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach (current guidance)
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2, 2017
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974
- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016
- Macleod's Clinical Examination, latest edition – History taking and general examination
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – The Practice of Medicine

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. فردا در سه مریض تعداد تنفس را واقعاً ۳۰ ثانیه بشمار.
۲. برای یک مریض بستری NEWS2 حساب کن و در دوسیه بنویس.

۳. یک درد را کامل با SOCRATES بپرس و یادداشت کن.
۴. در هر مریض جدید Shock Index را در ذهن حساب کن.
۵. یک مریض را با SOAP به استاد خود معرفی کن – در کمتر از ۲ دقیقه.

اتصال به فصل‌های بعدی (Compound Effect)

این فصل پایه همه کتاب است؛ هر فصل بعدی از همین ابزار استفاده می‌کند:

- SOCRATES ← درد قفسه سینه در فصل ۸ (ACS)، درد بطن در فصل ۲۷ (بطن حاد)، سردردی در فصل ۷۴.
- CPR ← ABCDE و شوک (فصل ۷۸)، DKA (فصل ۴۷)، مسمومیت‌ها (فصل‌های ۷۹-۸۱).
- فشار خون و Shock Index ← فشار بلند خون (فصل ۶)، سپسیس (فصل ۶۰).
- NEWS2 و qSOFA ← سپسیس (فصل ۶۰)، پنومونی (فصل ۱۸).
- GCS ← سکنه مغزی (فصل ۷۲)، مننژیت (فصل ۷۵)، مسمومیت‌ها.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ناپایدار: اول تاریخچه یا ABCDE؟ ABCDE.
۲. Shock Index چطور حساب می‌شود و حد خطر آن چند است؟ نبض ÷ سیستولیک؛ < 1 .
۳. علامت حیاتی هفتم در مریض گیج؟ گلوکوز خون.
۴. GCS چند یعنی راه هوایی در خطر؟ ≥ 8 .
۵. NEWS2 چند = تیم عاجل؟ ≥ 7 (یا ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل).

فصل ۲ – تفسیر ECG به روش الگوریتمی (Electrocardiogram Interpretation)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: ECG مانند ۱۲ کمره امنیتی است که از ۱۲ زاویه مختلف یک خانه (قلب) را فلم می‌گیرند. هر کمره فقط دیوار روبه‌روی خود را خوب می‌بیند. اگر دو کمره هم‌جوار یک دیوار را «سوخته» (ST elevation) نشان دهند، می‌دانیم آتش در کدام اتاق است: II، III و aVF دیوار پایینی، V1–V4 دیوار قدامی، و I، aVL، V5–V6، دیوار جانبی.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

ECG فعالیت برقی قلب را روی کاغذ ثبت می‌کند. داکتر خوب ECG را هر بار به یک ترتیب ثابت می‌خواند. تشخیص «از روی ظاهر» (Pattern recognition) برای استاد خوب است، اما برای محصل و داکتر جوان باعث از دست رفتن یافته‌ها می‌شود. فرمول ۸ گامی: مشخصات و کالبریشن ← P ← Axis ← Rhythm ← Rate ← ST ← QRS ← PR ← QT ← T – و در پایان: مقایسه با ECG قبلی و وضعیت مریض.

{ ECG: «Memory Jogger» را تداوی نکن؛ مریض را تداوی کن. ECG همیشه در کنار شکایت و علایم حیاتی تفسیر می‌شود. }

۲. اساس کاغذ و لیدها

کاغذ استاندارد (۲۵ mm/s و ۱۰ mm/mV):

واحد	زمان	ولتاژ
یک خانه بزرگ (۵ mm)	۰.۲۰ ثانیه (۲۰۰ ms)	۰.۵ mV
۵ خانه بزرگ	۱ ثانیه	–

اول کالبریشن را ببین: مستطیل ۱۰ mm بلند. اگر ۵ mm باشد (نیم کالبریشن)، ولتاژها دو برابر حقیقی‌اند. لیدها و دیوارهای قلب (نقشه شریان‌ها):

دیوار	لیدها	شریان معمول
سپتال (Septal)	V1–V2	LAD (شاخه‌های سپتال)
قدامی (Anterior)	V3–V4	LAD
جانبی (Lateral)	I، aVL، V5–V6	LCx یا شاخه Diagonal از LAD
خلفی (Posterior)	ST depression در V1–V3 (تصویر آینه‌ای)؛ ST elevation در V7–V9	RCA یا LCx
بطین راست (RV)	ST elevation در V4R	RCA پروکسیمال

۳. الگوریتم ۸ گامی – گام به گام

گام ۱ – مشخصات

نام مریض، تاریخ و ساعت ثبت، سرعت کاغذ، کالبریشن. ECG بدون ساعت در مریض درد قفسه سینه تقریباً بی‌ارزش است.

گام ۲ – تعداد ضربان (Rate)

- ریتم منظم: $\text{Rate} = 300 \div \text{تعداد خانه‌های بزرگ بین دو R (یا } 1500 \div \text{خانه‌های کوچک)}$.
- یاد بگیر: ۱ خانه = ۳۰۰، ۲ = ۱۵۰، ۳ = ۱۰۰، ۴ = ۷۵، ۵ = ۶۰، ۶ = ۵۰.
- ریتم نامنظم (مثل AF): تعداد QRS در نوار ۱۰ ثانیه‌ای (Rhythm strip) $\times 6$.
- طبیعی ۶۰–۱۰۰: کمتر = برادیکاردی، بیشتر = تاکیکاردی.

گام ۳ – ریتم (Rhythm)

سه سؤال:

- آیا R–R منظم است؟ (یک کاغذ را کنار نوار بگذار و R ها را نشانی کن)
- آیا پیش از هر QRS یک P هست و بعد از هر P یک QRS؟

- آیا P در لید II مثبت و در aVR منفی است؟ (= منشأ سینوسی)
همه «بلی» = ریتم سینوسی (Sinus Rhythm).

یافته	فکر کن
موج‌های اره‌ای (Saw-tooth) در II، III، aVF؛ معمولاً rate بطنی حدود ۱۵۰	فلاتر دهلیزی (Atrial Flutter)
تاکیکاردی منظم با QRS باریک، P دیده نمی‌شود	SVT (مثلاً AVNRT)
تاکیکاردی با QRS پهن (≥ 120 ms)	VT تا خلاف آن ثابت شود

▲ تاکیکاردی با QRS پهن در مریض ناپایدار = VT؛ کاردیوورژن سنکرونیز فوری (→ فصل ۷۸). «شاید SVT با aberrancy باشد» دلیل تأخیر نیست.

گام ۴ – محور (Axis)

روش سریع دو لیدی (I و aVF):

لید I	لید aVF	محور
مثبت ↑	منفی ↓	انحراف به چپ – لید II را ببین: اگر II هم منفی بود، LAD حقیقی است (بلاک فاسیکل قدامی چپ، MI، LVH پایینی)
منفی ↓	مثبت ↑	انحراف به راست (RVH، PE، COPD). بلاک فاسیکل خلفی چپ؛ در افراد جوان و لاغر ممکن طبیعی باشد
منفی ↓	منفی ↓	محور شدید (Extreme) – VT، اشتباه در جای لیدها

«دو دست بالا (I و aVF مثبت) = همه چیز خوب؛ دست‌ها از هم دور = چپ؛ دست‌ها به هم نزدیک = راست.»

گام ۵ – موج P و فاصله PR

- P طبیعی: کمتر از ۱۲۰ ms پهن و کمتر از ۲.۵ mm بلندی (در II).
- P بلند و نوک‌تیز (P pulmonale) ← بزرگی دهلیز راست.
- P پهن و دوکوهانه (P mitrale) ← بزرگی دهلیز چپ (مثلاً تنگی میترال).
- PR طبیعی: ۱۲۰–۲۰۰ ms (۳–۵ خانه کوچک).

تشخیص	PR
بلاک درجه اول	< 200 ms، ثابت
درجه دوم Mobitz I (Wenckebach) – معمولاً خوش‌خیم	طولانی‌شدن تدریجی تا یک QRS حذف شود
درجه دوم Mobitz II – خطر پیشرفت به بلاک کامل؛ پیس‌میکر	PR ثابت، ناگهان یک QRS حذف
بلاک درجه سوم (کامل) – عاجل	P و QRS کاملاً بی‌ربط به یکدیگر

گام ۶ – کمپلکس QRS

- پهن: طبیعی > 120 ms (کمتر از ۳ خانه کوچک).
- $QRS \geq 120$ ms: بلاک شاخه‌ای، ریتم بطنی، هایپرکالمی، مسمومیت با دواهای کانال سودیم (مثل انتی‌دیپرسیانت‌های سه‌حلقه‌ای)، ریتم پیس‌میکر.

بلاک شاخه‌ای	V1	V6	یادسپار
LBBB	QS یا rS عمیق («W»)	R پهن و بریده («M»)	W: M در V1، V6 در V6

▲ LBBB جدید با درد قفسه سینۀ ایسکمیک همانند STEMI جدی گرفته می‌شود؛ معیارهای Sgarbossa برای تشخیص MI در زمینه LBBB به کار می‌روند (→ فصل ۸).

- موج Q پاتولوژیک: پهن ≥ 40 ms یا عمق بیش از ۲۵٪ R همان لید ← MI قبلی.
- LVH (معیار Sokolow–Lyon): S در $V1 + R$ در $V5$ یا $V6 \geq 35$ mm. همراه با ST depression و T inversion جانبی (Strain pattern) ← فشار بلند خون مزمن یا تنگی اورت (→ فصل ۶).
- ولتاژ پایین: $QRS < 5$ mm در همه لیدهای اطراف ← افیوژن پریکارد، چاقی، COPD، هایپوتایروئیدی.
- Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربان به ضربان) + ولتاژ پایین + تاکیکاردی ← تامپوناد (→ فصل ۱۱).

گام ۷ – قطعه ST و موج T

ST elevation – تشخیص تفریقی:

حالت	شکل ST	نکته تمایز
پریکاردیت	مقعر (Saddle)، گسترده در اکثر لیدها	PR depression؛ بدون تغییر آینه‌ای (به جز aVR)
Early repolarization	مقعر با شکاف در نقطه J، جوانان	بدون تغییر در سیر زمان، بدون علائم
LBBB / ریتم پیس	Discordant	ST elevation ثانوی در بلاک
آنوریسم بطن چپ	ST elevation پایدار	Q عمیق، MI قدیمی
Brugada	Coved ST در $V1-V2$	خطر مرگ ناگهانی، سابقه فامیلی

معیار STEMI (ESC 2023 / تعریف چهارم MI): ST elevation جدید در نقطه J در دو لید هم‌جوار:

- $V2-V3$: در مردان ≥ 2 mm، در مردان > 40 سال، ≥ 2.5 mm در زنان ≥ 1.5 mm
- سایر لیدها: ≥ 1 mm

ST depression: ایسکمی ساب‌اندوکاردیال/ NSTEMI، تغییر آینه‌ای STEMI، اثر دیجوکسین (شکل «داس» یا Reverse tick)، LVH strain، هایپوکالمی. Δ به aVR نگاه کن: ST elevation در aVR همراه با ST depression گسترده $\leftarrow$ ایسکمی شدید منتشر (مرض Left main یا سه‌رگی) – عاجل. موج T:

- T بلند و نوک‌تیز (Peaked): هایپرکالمی ($\rightarrow$ فصل ۴۲)؛ یا T هایپراکیوت در مراحل اول STEMI.
- T inversion: ایسکمی، Wellens (T عمیق یا دوفازی در $V2-V3$ $\leftarrow$ تنگی شدید LAD پروکسیمال؛ تست ورزش ممنوع)، PE (در $V1-V4$ همراه با $S1Q3T3$)، T، LVH strain منفی در aVR و گاهی III و $V1$ طبیعی است.

گام ۸ – فاصله QT

- QT را از آغاز QRS تا پایان T اندازه کن و اصلاح بر اساس Rate کن:
- Bazett: $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$ (به ثانیه) – در Rate بالا بیش‌برآورد می‌کند؛ در تاقیکاردی $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$ Fridericia بهتر است.
- QT_c طبیعی: کمتر از حدود 450 ms در مرد و 460 ms در زن. $QT_c > 500$ ms = خطر بالای Torsades de Pointes.
- قاعده سریع: اگر QT کمتر از نصف R-R باشد، معمولاً طبیعی است (در Rate طبیعی).

QT کوتاه	QT طولانی
دایجوکسین	دواها: Macrolide ها (Azithromycin، Clarithromycin)، Fluoroquinolone ها، Haloperidol، Ondansetron، Methadone، Amiodarone، انتی‌ملاریاها (Quinine، Chloroquine)
QT کوتاه اثری	هایپوترمی، خونریزی مغزی، QT طولانی اثری

{ پیش از تجویز هر دوا QT-طولانی‌کننده در مریض دارای خطر، ECG و الکترولیت‌ها (K^+ و Mg^{2+}) را چک کن. }

۴. الگوهای مهم «یک‌نگاه» (Spot Diagnoses)

الگو	یافته‌های کلیدی	فصل
هایپوکالمی	T صاف، موج QT (QU)، ST depression، U طولانی	۴۲
PE	شایع‌ترین یافته تاقیکاردی سینوسی؛ $S1Q3T3$ نادر و غیراختصاصی؛ RBBB جدید، $V1$ –T inversion، $V4$ ، انحراف محور به راست	۱۴
پریکاردیت	ST elevation مقعر گسترده + PR depression	۱۱
مسمومیت دیجوکسین	اکستراسیستول‌های بطینی، تاقیکاردی دهلیزی با بلاک، بلاک AV؛ «Reverse tick» اثر دوا است، نه مسمومیت	۱۰
هایپوترمی	موج Osborn (J wave)، برادیکاردی، QT طولانی	۸۳
WPW	PR کوتاه، موج دلتا، QRS کمی پهن	۱۰

۵. نمونه گزارش ECG (قالب نوشتن در دوسیه)

{ «۱۲ ECG لیدی، ساعت ۱۴:۲۰، کالیبریشن استاندارد. ریتم سینوسی، 108 Rate. محور طبیعی. QRS. PR 160 ms. باریک (90 ms). ST elevation 3 mm در III، II و aVF با ST depression آینه‌ای در I و aVL . نتیجه: STEMI پایینی – $V4R$ برای RV گرفته شود؛ مقایسه با ECG قبلی موجود نیست.» }

۶. اشتباهات رایج

- جابه‌جا بستن لیدهای دست‌ها (I کاملاً منفی و aVR مثبت در ریتم سینوسی $\leftarrow$ اول لیدها را چک کن، بعد به Dextrocardia فکر کن).
- یک ECG نرمال ACS را رد نمی‌کند – ECG را هر 15 – 30 دقیقه تکرار کن اگر درد ادامه دارد.
- فراموش کردن $V4R$ در MI پایینی و $V7-V9$ در ST depression قدامی.
- اعتماد کامل به تفسیر خودکار ماشین – به‌ویژه در QT و ریتم.
- ندیدن ECG قبلی مریض.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. هر بار یک ترتیب: Rate ← Rhythm ← Axis ← PR ← QRS ← ST/T ← QT.
۲. $300 \div$ خانه‌های بزرگ = Rate؛ در ریتم نامنظم: QRS در ۱۰ ثانیه $\times 6$.
۳. I و aVF هر دو مثبت = محور طبیعی.
۴. MaRRoW = RBBB، WiLLiaM = LBBB.
۵. Mobitz II و بلاک کامل = پیس‌میکر؛ Wenckebach معمولاً خوش‌خیم.
۶. STEMI = محدب + ناحیه شریانی + تغییر آینه‌ای؛ پریکاردیت = مقعر + گسترده + PR depression.
۷. T نوک‌تیز = پتاسیم را همین حالا چک کن.
۸. QTc > 500 ms = خطر Torsades — دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن و K^+/Mg^{2+} را اصلاح کن.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. ST elevation در دو لید هم‌جوار با درد قفسه سینه ← STEMI: فعال‌سازی PCI یا ترومبولیز (→ فصل ۸).
۲. تاکیکاردی با QRS پهن ← VT تا خلاف آن ثابت شود؛ ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز.
۳. بلاک درجه سوم یا Mobitz II با هایپوتنشن/سینکوپ ← Atropine، پیس ترانس کوتانیوس (→ فصل ۱۰).
۴. QRS پهن + T نوک‌تیز ← هایپرکالمی شدید: ۱۰ mL IV 10% Calcium gluconate در ۵-۱۰ دقیقه فوری (→ فصل ۴۲).
۵. Wellens pattern ← تنگی بحرانی LAD؛ تست ورزش ممنوع، ارجاع برای انژیوگرافی.
۶. ST elevation در aVR + ST depression منتشر ← ایسکمی Left main/سه‌رگی.
۷. QTc > 500 ms یا QTc ۲ g IV Magnesium sulfate ← Torsades در ۱۰-۱۵ دقیقه (→ فصل ۱۰).

References

- Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J 2019
- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023
- Rautaharju PM, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG, Part IV (ST, T, U waves and QT). Circulation 2009
- Resuscitation Council UK / ERC Guidelines 2021 — Adult Advanced Life Support (tachycardia & bradycardia algorithms)
- Hampton J. The ECG Made Easy, latest edition
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Electrocardiography

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر روز یک ECG را با الگوریتم ۸ گامی بخوان و گزارش بنویس — پیش از دیدن تفسیر ماشین.
۲. در سه ECG محور را فقط با I و aVF در کمتر از ۱۰ ثانیه تعیین کن.
۳. در یک ECG، QTc را با Bazett حساب کن.
۴. در هر مریض MI پایینی، V4R را خودت بگیر.
۵. یک ECG قدیمی مریض را پیدا کن و با ECG جدید مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ECG بخش «C» در ABCDE است؛ در درد قفسه سینه ECG در ۱۰ دقیقه.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): LVH با معیار Sokolow-Lyon = آسیب ارگان هدف.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): AF، LBBB (کاندید CRT اگر $QRS \geq 130$ ms)، Q قدیمی.
- فصل ۸ (ACS): معیار STEMI، نقشه شریان‌ها، V4R.
- بعداً: اریتمی‌ها (فصل ۱۰)، پریکاردیت (۱۱)، PE (۱۴)، الکتروولیت‌ها (۴۲)، مسمومیت‌ها (۷۹-۸۱).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. بین دو R چهار خانه بزرگ است؛ Rate؟ ۷۵.
۲. I مثبت، aVF منفی، II منفی؛ انحراف محور به چپ.
۳. M در V1 و W در V6؟ RBBB.
۴. ST elevation مقعر گسترده با PR depression؟ پریکاردیت.
۵. QTc چند = خطر Torsades؟ $500 < \text{ms}$.

فصل ۳ – خواندن سیستماتیک رادیوگرافی صدر (Chest X-ray)

(Interpretation)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: رادیوگرافی صدر مانند سایه دست روی دیوار است. هوا شعاع را عبور می‌دهد و سیاه می‌شود؛ استخوان و فلز شعاع را می‌گیرند و سفید می‌شوند؛ آب، خون و عضله خاکستری اند. هر مرض ریه یعنی جایی که باید سیاه باشد سفید شده (مایع، چرک، تومور) یا جایی که باید خاکستری باشد سیاه شده (هوا در جای غلط).

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

CXR ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین معاینه تصویری در شفاخانه‌های افغانستان است. خطای اصلی خواننده «نگاه کردن» بدون «دیدن» است: چشم به اولین یافته واضح می‌چسبد و یافته دوم (مثلاً پنوموتوراکس کوچک یا کتله پشت قلب) از دست می‌رود. راه‌حل: یک ترتیب ثابت، هر بار. فرمول: کیفیت (RIPE) ← ABCDE رادیولوژیک ← مناطق پنهان ← مقایسه با فلم قبلی ← یک جمله نتیجه

{ Memory Jogger: «بیشترین چیزی که از دست می‌رود، دومین یافته است.» }

۲. گام اول – مشخصات و کیفیت فلم (RIPE)

پیش از آن‌که به ریه‌ها نگاه کنی: نام، تاریخ، نوع فلم (PA یا AP)، وضعیت (ایستاده یا خوابیده)، و علامت چپ/راست.

حرف	معیار	فلم خوب
I – Inspiration (شهیق)	تعداد اضلاع قدامی دیده شده بالای دیافراگم راست	۵-۶ ضلع قدامی (یا ۸-۱۰ ضلع خلفی)
P – Projection (نوع)	PA (استندرد) یا AP (مریض بستری/شدید)	در AP قلب بزرگ‌تر دیده می‌شود
E – Exposure (نفوذ)	فقرات صدری پشت قلب	به‌سختی دیده شوند

▲ در فلم AP یا خوابیده، اندازه قلب را قضاوت نکن؛ و در فلم خوابیده، مایع جنب و هوا (پنوموتوراکس) شکل متفاوت دارند (پنوموتوراکس در قدام جمع می‌شود – علامت Deep sulcus).

۳. گام دوم – ABCDE رادیولوژیک

چک‌لیست:

حرف	ساختار	چه ببینی
B – Breathing (ریه‌ها و جنب)	مقایسه بالا، وسط و پایین هر دو ریه	کدورت، شفافیت اضافی، خطوط جنب، زاویه کاستوفرنیک
C – Circulation (قلب و منصف)	اندازه و شکل قلب، منصف، هیلوم‌ها	CTR (نسبت قلب به صدر)، منصف پهن، هیلوم بزرگ
D – Diaphragm	ارتفاع، شکل، هوا زیر دیافراگم	راست معمولاً ۱-۳ cm بلندتر؛ هوای آزاد زیر دیافراگم = انثقاب احشا (Perforation)
E – Everything else	استخوان‌ها، انساج نرم، وسایل	کسر ضلع، ضایعات لیتیک، امفیزم زیرجلدی، جای تیوب‌ها و کتترها

نسبت قلب به صدر (Cardiothoracic Ratio): بیشترین عرض قلب ÷ بیشترین عرض داخلی صدر. در فلم PA بیش از ۰.۵ = کاردیومگالی (→ فصل ۷).

۴. گام سوم – مناطق پنهان (Review Areas)

پیش از نتیجه‌گیری، این پنج جای را دوباره ببین:

- رأس‌ها (Apices) – توبرکلوز، تومور Pancoast، پنوموتوراکس کوچک
- پشت قلب – کلاپس لوب پایینی چپ (علامت «بادبان» یا Sail sign)، هرنیای هیاتل
- هیلوم‌ها – لمفادنوپاتی، کتله

- □ زیر دیافراگم – هوای آزاد، کتله بطنی
- □ زوایای کاستوفرنیک – افیوژن کوچک (حدود ۲۰۰ mL یا بیشتر لازم است تا در PA کند شوند)

۵. نشانه‌های رادیولوژیک کلیدی

نشانه	معنا
Air bronchogram	برونکوس‌های پر از هوا در میان آلوئول‌های پر از مایع ← Consolidation (پنومونی)، نه کتله یا افیوژن
Meniscus sign	کنارهٔ مقعر بالارونده به طرف جدار ← افیوژن جنب
Air–fluid level در یک حفره	ابسهٔ ریه، کاویتی انتانی (→ فصل ۲۱)
Kerley B lines	خطوط کوتاه افقی در محیط قاعده‌ها ← ادم بین‌النسجی (عدم کفایت قلب)
Bat-wing (Butterfly)	کدورت دوطرفهٔ اطراف هیلوم ← ادم ریوی آلوئولی
خط جنب احتشایی بدون نشانه‌های ریوی در محیط	پنوموتوراکس

۶. الگوهای مهم – جدول تفریقی

الگو	یافتهٔ CXR	قصبه‌الریه/منصف	فصل
کلاپس (Atelectasis)	کدورت + کاهش حجم، بالا رفتن دیافراگم، شیفت شقاق‌ها	به طرف کلاپس	۲۱
افیوژن جنب بزرگ	کدورت قاعده‌ای با Meniscus	دور از افیوژن	۲۰
پنوموتوراکس تحت فشار	سیاهی بدون نشانه‌های ریوی، ریهٔ فشرده	دور از پنوموتوراکس	۲۰
ادم ریوی (کاردیوژنیک)	کاردیومگالی، توزیع مجدد عروق به بالا، Bat-wing، Kerley B، افیوژن دوطرفه	در وسط	۷
توبرکلوز ثانوی (Post-primary)	کدورت و کاویتی در رأس‌ها/قطعهٔ فوقانی لوب پایینی، فیبروز، کلسیفیکیشن	ممکن به طرف فیبروز	۱۹
توبرکلوز میلیاری	صدها ندول ۱–۳ mm منتشر	در وسط	۱۹
COPD / امفیزم	ریه‌های بیش‌ازحد متسع، دیافراگم صاف، بیش از ۶–۷ ضلع قدامی، قلب باریک	در وسط	۱۶
ARDS	کدورت دوطرفهٔ منتشر، قلب معمولاً طبیعی، بدون افیوژن بزرگ	در وسط	۲۲
کیست هایداتید	کتلهٔ گرد صاف؛ در صورت پاره شدن: «Water lily sign»	–	۲۱

قاعدهٔ حجم: «کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هُل می‌دهند.» جهت قصبه‌الریه نصف تشخیص است.

۷. وسایل طبی – جای درست

وسيله	جای درست
کتتر ورید مرکزی (CVC)	نوک در ورید اجوف فوقانی نزدیک مدخل دهلیز راست؛ پس از جاگذاری پنوموتوراکس را رد کن
تیوب معدی (NG)	زیر دیافراگم در معده؛ از برونکوس پیروی نکند – پیش از تغذیه تأیید شود
Chest drain	سوراخ‌های جانبی همه داخل صدر

۸. نمونهٔ گزارش (قالب دوسیه)

{ «CXR PA ایستاده، ۲۴/۹، چرخش ندارد، شهیق کافی (۶ ضلع قدامی). قصبه‌الریه در وسط. کدورت متجانس در منطقهٔ پایینی راست با Air bronchogram و از بین رفتن کنارهٔ دیافراگم راست؛ کنارهٔ راست قلب واضح. زاویه‌ها آزاد. CTR ۰.۴۵. هوای آزاد زیر دیافراگم نیست. استخوان‌ها سالم. نتیجه: Consolidation لوب پایینی راست – مطابق پنومونی. CXR پیگیری پس از ۶ هفته در مریض سگرتی یا بالای ۵۰ سال برای رد کتلهٔ زمینه‌ای.» }

۹. اشتباهات رایج

- قضاوت اندازه قلب در فلم AP.
- توقف پس از اولین یافته (Satisfaction of search).
- ندیدن رأس‌ها و پشت قلب.
- CXR نرمال PE، مراحل اول پنومونی، یا توبرکلوز در مریض HIV مثبت را رد نمی‌کند.
- «نوک تیوب معدی» را با دیدن فقط بخش بالایی فلم تأیید کردن.
- مقایسه نکردن با فلم قبلی – یک ندول «قدیمی و ثابت» بسیار آرام‌کننده‌تر از ندول نو است.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. RIPE پیش از ریه: Rotation، Inspiration، Exposure، Projection (۵-۶ ضلع قدامی).
۲. CTR > ۰.۵ فقط در PA معنی کاردیومگالی دارد.
۳. Silhouette: کناره راست قلب = لوب میانی؛ کناره چپ قلب = لینگولا؛ دیافراگم = لوب پایینی.
۴. Air bronchogram = Consolidation.
۵. کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.
۶. پنج منطقه پنهان: رأس‌ها، پشت قلب، هیلوم‌ها، زیر دیافراگم، زوایا.
۷. رأس + کاویتی = توبرکلوز تا خلاف آن ثابت شود – مریض را جدا کن و بلغم برای GeneXpert بفرست.
۸. پس از هر CXR، CVC برای پنوموتوراکس.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. پنوموتوراکس + انحراف قصبه‌الریه + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس تحت فشار؛ تشخیص کلینیکی است – برای CXR منتظر نمان: Needle decompression فوری (→ فصل ۲۰).
۲. هوای آزاد زیر دیافراگم ← انثقاب احشا (Perforation): جراحی عاجل (→ فصل ۲۷).
۳. منصف پهن + درد قفسه سینه پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت: CT انجیوگرافی (→ فصل ۱۳).
۴. ادم ریوی دوطرفه + هایپوکسیمی ← عدم کفایت حاد قلب یا ARDS (→ فصل‌های ۷ و ۲۲).
۵. تیوب معدی در برونکوس ← تغذیه نکن؛ تیوب را بکش.
۶. کاویتی رأس‌ها در مریض سرفه‌دار ← انتقال توبرکلوز: جداسازی تنفسی.

References

- Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy, latest edition
- Royal College of Radiologists / NHS Improvement. Patient safety alert: Nasogastric tube misplacement – confirmation of position
- Light RW. Pleural Diseases, latest edition (radiological detection of effusions)
- WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 2 – Screening, 2021 (role of CXR)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diagnostic procedures in respiratory disease

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر CXR را با RIPE شروع کن – حتی وقتی یافته واضح است.
۲. در سه CXR، CTR را با خطکش اندازه کن.
۳. در هر CXR پنج منطقه پنهان را با انگشت نشان بده.
۴. یک CXR را با یک فلم قبلی همان مریض مقایسه کن.
۵. پس از هر CVC یا تیوب معدی، جای آن را خودت روی فلم تأیید کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): CXR بخش «B» در ABCDE مریض تنگی نفس است؛ همان ترتیب ABCDE در خواندن فلم تکرار می‌شود.

- فصل ۲ (ECG): ECG و CXR دو معاینه پایه هر درد قفسه سینه و تنگی نفس اند.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): کاردیومگالی، Kerley B، Bat-wing.
- بعداً: پنومونی (۱۸)، توبرکلوز (۱۹)، جنب و پنوموتوراکس (۲۰)، (۲۲) ARDS، بطن حاد (۲۷).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چند ضلع قدامی = شهیق کافی؟ ۵-۶.
۲. ۵۵٪ CTR در فلم AP کاردیومگالی است؟ قابل قضاوت نیست – فقط PA.
۳. کناره راست قلب محو است؛ کدام لوب؟ لوب میانی راست.
۴. کدورت + قصبه‌الریه به طرف کدورت کشیده شده؟ کلاپس.
۵. پنوموتوراکس تحت فشار مشکوک در مریض ناپایدار: اول CXR؟ نه – Needle decompression فوری.

فصل ۶ – فشار بلند خون و بحران هایپر تینسیو (Hypertension)

(& Hypertensive Crisis)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهني: فشار خون بالا مثل شلنگ آب است که شيرش نيمه بسته کرده‌اي: آب (خون) هنوز جريان دارد و مريض اغلب هيچ درد نمی‌کند، اما ديواره شلنگ (عروق) سال به سال از داخل فرسوده و پاره می‌شود – تا روزی که یک بارگه ترکاند: سکنه مغزی، سکنه قلبي یا پاره شدن رگ. مريض فشار بلند خون را «مريض بی‌صدا» می‌نامند چون خود فشار، درد ندارد؛ فقط آسیب‌هایی که می‌کند درد دارند.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فشار بلند خون (Hypertension) حالتی است که در آن نیروی خون بر دیواره شریان‌ها به‌طور مزمن بالا رفته و به ارگان‌های هدف (قلب، مغز، گرده، چشم و عروق بزرگ) آسیب می‌زند. دو صورت دارد:

- فشار بلند خون مزمن (Chronic Hypertension): کشف آرام در کلینیک یا شفاخانه، اغلب بدون اعراض.
- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Crisis): فشار بسیار بالا با (مرگبر) آسیب حاد ارگان هدف – این وضعیت شفاخانه‌ای و جان‌سوز است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (ACC/AHA 2017 و ESC 2023): فشار خون اندازه‌گیری‌شده در کلینیک با مانومتر صحیح، در موقع نشسته، دست در سطح قلب، بعد از ۵ دقیقه استراحت:

- فشار سیستولیک (Systolic): فشار هنگام انقباض قلب
- فشار دیاستولیک (Diastolic): فشار هنگام استراحت قلب

طبقه‌بندی	سیستولیک (mmHg)	یا	دیاستولیک (mmHg)
افزایش یافته (Elevated)	۱۲۰-۱۲۹	و	کمتر از ۸۰
مرحله ۱ (Stage 1)	۱۳۰-۱۳۹	یا	۸۰-۸۹
مرحله ۲ (Stage 2)	۱۴۰ به بالا	یا	۹۰ به بالا
مرحله ۳ (Stage 3)	۱۸۰ به بالا	یا	۱۱۰ به بالا

{ نکته: یک بار فشار بالا تشخیص نیست. فشار بلند خون حداقل در دو ملاقات جدا (یا با ABPM/HBPM تأیید شده) ثبت می‌شود – مگر فشار بالای ۱۸۰/۱۱۰. { تصنیف بحران هایپر تینسیو:

- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Emergency): فشار بالا + آسیب حاد ارگان هدف (سکنه، عدم کفایه قلب، خونریزی مغزی، آنوریسم پاره، عدم کفایه حاد گرده، رتینوپاتی درجه ۳-۴، درد سینه عروقی).
- فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency): فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد ارگان هدف.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: فشار خون = قوای قلبی (Cardiac Output) × مقاومت عروقی محیطی (SVR) هر چیزی که حجم خون (نمک، آب) یا مقاومت عروق کوچک (آدنالین، آنژیوتانسین) را بالا ببرد، فشار را بالا می‌برد:

- قدم ۱ – افزایش نگهداری نمک و آب: رنین (Renin) از گرده → آنژیوتانسین (Angiotensin II) از ریه → انقباض عروق + ترشح آلدوسترون (Aldosterone) از فوق‌گرده → نگهداری سدیم و آب → افزایش حجم خون.
- قدم ۲ – فعالی‌شدن سیستم عصبی سیمپاتیک: استرس، چاقی، کم‌تحركی → آدنالین و نورآدنالین بیشتر → انقباض عروق و افزایش ضربان.
- قدم ۳ – آسیب اندوتلیال (Endothelial Injury): فشار بالا دیواره رگ را می‌لاید → لیپیدهای خونی در دیواره جمع می‌شوند → اتروسکلروز (Atherosclerosis) → عروق سخت و تنگ.

۴. قدم ۴ – بازبناشوندگی قلب (Left Ventricular Hypertrophy): قلب برای پمپاژ در برابر مقاومت بالا، عضلهٔ چپ ضخیم می‌شود → بعداً ناکار و نارس.
۵. قدم ۵ – آسیب گرده و چشم: رگ‌های ریز گرده می‌پایینند (CKD) و رگ‌های رتینا می‌شکنند (رتینوپاتی).
تصویر: «فشار بالا → دیوارهٔ رگ می‌لاید → رگ سخت می‌شود → فشار بیشتر می‌شود» – این حلقهٔ فاصله‌دار (Vicious Cycle) است که فشار بلند خون را از یک عدد به یک امراض ارگان‌سوز تبدیل می‌کند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

الف) فشار بلند خون اولیه (Primary/Essential) – حدود ۹۰-۹۵ فیصد موارد بدون سبب مشخص؛ ترکیب ژنتیک + محیط:

فکتور	توضیح
افزایش سن	بعد از ۵۰ سالگی شایع می‌شود
زیاد نمک (Salt)	بیشتر از ۵-۶ گرم نمک در روز
چاقی و چاقی شکمی	فیصد چربی شکمی بالای حد
کم‌حرکی	کمتر از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته
سیگار و نیکوتین	انقباض عروق حاد + اتروسکلسروز
الکلی زیاد	بالای ۲ واحد در روز
استرس مزمن و کم‌خوابی	فعال‌شدن سیمپاتیک مزمن
کمبود پتاسیم (Potassium)	تغذیه کم سبزیجات و میوه
صدای زیاد و آسپیرین زیاد	فکتورهای مساعد کوچک

ب) فشار بلند خون ثانویه (Secondary) – ۵-۱۰ فیصد موارد △ در صورت‌های زیر حتماً به سبب ثانویه فکر کن (فصل ۵۰ – غدوات):

سبب ثانویه	کلید تشخیصی
سیندرم کوشینگ / تورم آدرنال	چاقی شکمی، مریضی صورت، ضعف عضلانی
درمهٔ فئوکروما	حمله‌های فشار + سرگرد + تعریق + تاکیکاردی (متانفرین ادرار)
آپنه خواب (OSA)	خروپف، چاقی، خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست (Coarctation)	فشار بالایی در بازو + پاهای کم‌پالس یا کم‌پالس
دواها: NSAID، کورتیکواستروئید، کونائین، دکانژستانت (Pseudoephedrine)	تاریخچهٔ مصرف دوا – همیشه بپرس
حاملگی / پری‌اکلامپسی	زه + فشار بعد از هفتهٔ ۲۰
هیپوتیرئیدی / هیپرتیرئیدی	معاینهٔ تایرئید

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض (Symptoms):

- بیشتر مریضان بدون اعراض هستند (سکتهٔ بی‌صدا – Silent Killer).
- ممکن است: سرگرد پشت سر (Occipital Headache) صبحگاهی، سرگیجه، تاریینی، خونریزی بینی (Epistaxis)، تنگی نفس در درجات بالا.

- △ اعراض ارگان‌سوز: درد سینه، تنگی نفس حاد، ضعف یک‌طرفه، دوبینی، سرگرد انفجاری، درد شکم/کمر شدید (دیسکسیون).

علائم (Signs):

- فشار خون بالا در دو اندازه‌گیری
- LVEF کم / LVH در ECG و Echo
- رتینوپاتی هیپرتنسیو (Hypertensive Retinopathy):
- درجه ۱: تنگی رگ‌های رتینا
- درجه ۲: تقاطع آرنی-ون (AV Nipping)
- درجه ۳: خونریزی و پات (Cotton Wool)
- درجه ۴: پندیدگی دسک (Papilledema) → مالگن
- وزش عروقی (Bruit): کاروتیدی، شکمی، رنل

- عدم کفایه قلب: رال‌های ریوی، JVP بالا، ادم
- آسیب عروق محیطی: پالس‌های ضعیف پا

۶. Clinical Examination (معاینه سیستماتیک)

چک‌لیست معاینه فشار بلند خون:

- اندازه‌گیری صحیح: مریض ۵ دقیقه نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها بی‌پیچ، دست در سطح قلب، مانومتر مناسب اندازه بازو
- اندازه‌گیری در هر دو بازو (اختلاف بالای ۱۰-۱۵ mmHg → به استنوز/دیسکسیون شک)
- اندازه‌گیری در دو پا (تشخیص کوشرست اورت)
- علایم حیاتی کامل + فیصد چربی (BMI) + محیط کمر
- قلب: ریتم، صدای S4 (علامت LVH)، وزش آئورت (استنوز)
- ریه: رال قاعده‌ای (عدم کفایه قلب)، کریپلوس
- عروق: پالس کاروتید (شدت، توالی)، پالس رادیال، فیملور، دوروئیس (اختلاف بازو/پا → انگیلی)
- وزش شکمی: روی شکم در وضعیتی (Renal Bruit)
- چشم: اوسکوپ (Ophthalmoscope) – رتینوپاتی
- نورولوژیک: رفلکس‌ها، قدرت عضلات، میدان بینایی
- بطن: جگر بزرگ (عدم کفایه قلب راست)، وزش رنل

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	نکته تمایز کلیدی
فشار ثانویه به استنوز رنل	وزش شکمی + CKD + مقاوم به دوا
درمه فئوکروما	حمله‌های دوره‌ای + سربرد + تعریق + تاکیکاردی
سیندرم کوشینگ	چاقی شکمی + مریضی صورت + ضعف + استریای
آپنه خواب	خروپف + چاقی + خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست اورت	بازوها فشار بالا + پاها فشار کم/بی‌پالس
پری‌اکلامپسی حاملگی	زه + فشار بعد از هفته ۲۰ + پروتینوری
بحران هایپرنتینسیو	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + آسیب حاد ارگان هدف
فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency)	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

بنیادی (هر مریض جدید):

- CBC، کراتینین/یوریا (RFT)، الکترولیت‌ها (K⁺, Na)، قند خون ناشتا / HbA1c
- لیپیدگرام، ادرار کامل + پروتینوری (Urine Protein/Creatinine Ratio)
- ECG لید (LVH، ایسکمی، آریتمی)
- معاینه قعر چشم (Fundoscopy)
- پیشرفته / خاص:
- Echo (تعیین LVEF، LVH، فشار شریان ریوی)
- ABPM یا HBPM (تأیید فشار، تشخیص فشار بالای ماسکت – White Coat HTN)
- تست عملکرد تیروئید (TSH)
- متانفرین‌های ادرار ۲۴ ساعته / کتکول‌های خون (شبهه فئوکروما)
- رنالدین/آلدوسترون (استنوز رنل/هایپرآلدوسترونیزم)؛ کورتیزول صبحگاهی (شبهه کوشینگ)
- CT/CTA شکم (استنوز شریان رنل، دیسکسیون اورت)
- MRI مغز (در بحران یا سربرد)
- اسلپ آپنی استادی (OSA)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص فشار بلند خون: فشار سیستولیک ≥ 140 یا دیاستولیک ≥ 90 mmHg در حداقل دو ملاقات (یا ABPM/HBPM تأیید شده).
- تشخیص بحران هایپرنتینسیو: فشار بالای $180/120$ + حداقل یک نشانه آسیب حاد ارگان هدف:
- سکته مغزی (ischemic/hemorrhagic) / TIA
- عدم کفایه حاد قلب / درد سینه عروقی
- خونریزی مغزی (Subarachnoid/Intracerebral)
- آنوریسم/دیسکسیون اورت
- عدم کفایه حاد گرده (AKI)
- رتینوپاتی درجه ۴ (پاپیلدیم)
- ادم ریوی حاد
- تشخیص فشار ثانویه: معاینات بالا + پاسخ بد به سه دوا + سرنخ‌های بالینی (وزن، پالس‌های غیرعادی، اعراض حمله‌ای).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم بحران هایپرنتینسیو:

۱. قدم ۱ – تشخیص نوع: آیا آسیب حاد ارگان هدف هست؟ (ECG، معاینه نورولوژیک، رادیوگرافی قفسه سینه، ادرار، قعر چشم، کراتینین)
 ۲. قدم ۲ – اگر Emergency: مریض به بخش عاجل / ICU، وریدی، مانیتور فشار، ECG، اکسیژن. هدف: در ساعت اول فشار را حداکثر ۲۵ فیصد کم کن (نه بیشتر!). در ۲-۶ ساعت به $160/100$ برسان.
 - استثنا – دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر 120 mmHg در ۲۰ دقیقه + کنترل درد + بتابلکر.
 - استثنا – سکته مغزی ischemic: اگر ترومبولیز ممکن است، فشار زیر $185/110$ نگاه دار.
 ۳. قدم ۳ – اگر Urgency: مریض را آرام کن، دواهای فمی شروع کن، در ۲۴-۴۸ ساعت تدریجی کاهش (نه سقوط!).
 ۴. قدم ۴ – پیگیری: مریض را ۱-۲ هفته بعد ببین، دواها را تعدیل کن.
- دواهای وریدی بحران هایپرنتینسیو (Dose + Route + Frequency + Duration):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Nicardipine	۵ mg/hr شروع، افزایش ۲.۵ mg/hr هر ۵-۱۵ دقیقه	IV (پمپ)	تا ۱۵ mg/hr	تا فشار هدف؛ سپس فمی
Nitroglycerin	۵-۱۰ mg/hr شروع، افزایش ۵-۱۰ mg/hr	IV (پمپ)	تا ۲۰۰ mg/hr	ویژه درد سینه/عدم کفایه قلب
Nitroprusside	۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr شروع	IV (پمپ)	تا ۱۰ mcg/kg/hr	فقط در ICU؛ خطر سیانور – بیش از ۷۲ ساعت نه
Clonidine	۰.۱-۰.۲ mg	PO / SL	یک بار	در Urgency؛ احتیاط در سکته مغزی (ریسک هایپوتنشن)

{ Δ هرگز فشار را در بحران به سرعت و کامل به نرمال نبر – خون‌رسانی مغز و گرده به فشار عادت کرده و سقوط فشار = سکته/عدم کفایه. }

ب) Pharmacotherapy (تداوی دویی فشار بلند خون مزمن)

استراتژی (AHA/ACC 2017 + ESC 2023 + R) همنمود جهانی:

- مرحله ۱ (Stage 1)، خطر کم: تغییر سبک زندگی ۳-۶ ماه → اگر فشار بالای $130/80$ باقی ماند، یک دوا.
- مرحله ۲ (Stage 2)، خطر بالا / ارگان آسیب دیده / دیابت (CKD): دو دوا از دو دسته مختلف همزمان (ترجیحاً ترکیب تک‌تابلت – Single Pill Combination).
- هدف فشار:
- عمومی: زیر $140/90$ mmHg
- دیابت / CKD / CVD: زیر $130/80$ mmHg
- مسنان (بالای ۶۵ سال): سیستولیک $130-135$ (اگر تحمل شود)
- دواهای خط اول (First-Line) – چهار دسته:

دسته	دوا نمونه	دوز شروع	دوز حداکثر	راه / تکرار	کنتراندیکاسیون / نکته
	Lisinopril	۵ mg	۴۰ mg	PO / OD	وزش خشک (Dry Cough) – عارضه رایج
	Ramipril	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	
ARB (Angiotensin Receptor Blocker)	Losartan	۵۰ mg	۱۰۰ mg	PO / OD	جایگزین ACEI اگر وزش؛ کنتراندیکاسیون‌ها مشابه
	Valsartan	۸۰ mg	۱۶۰ mg	PO / OD	
	Telmisartan	۴۰ mg	۸۰ mg	PO / OD	
CCB (Calcium Channel Blocker)	Amlodipine	۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	ادم پا (سایده)؛ در مسنان عالی
	Nifedipine ER	۳۰ mg	۶۰ mg	PO / OD	فقط شکل کند (ER/XT) – شکل فوری ممنوع (سقوط فشار)
Thiazide	HCTZ (Hydrochlorothiazide)	۱۲.۵ mg	۲۵ mg	PO / OD	اسید اوریک / نقرس، CKD (eGFR < ۳۰) – دیورتیک لوپ Furosemide استفاده کن
	Indapamide	۱.۵ mg	۱.۵ mg	PO / OD	
Betablocker (خط دوم)	Bisoprolol	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	آسم شدید، بلوک قلبی، تاکیکاردی
	Metoprolol Succinate	۲۵ mg	۲۰۰ mg	PO / OD	

- Memory Jogger: «A + C» = ACEI/ARB + CCB – ترکیب کلاسیک خط اول. «ACEI + ARB» هرگز با هم (خطر K* بالا + عدم کفایه گرده). «Nifedipine فوری» ممنوع – فقط ER. { ترکیب‌های معمول (Stepwise):
۱. ACEI + CCB یا ACEI + Thiazide یا ARB + CCB
 ۲. اگر کنترل نشد: سه‌تایی = ACEI/ARB + CCB + Thiazide
 ۳. اگر باز هم بالا: Resistant Hypertension → دواهای چهارم: PO/OD ۲۵–۵۰ mg Spironolactone (بهترین دوا چهارم) یا Betablocker یا Doxazosin
- تعدیل دوز در عدم کفایه گرده (eGFR < ۳۰):
- Thiazide اثر کم → PO/OD ۴۰–۸۰ mg Furosemide یا BID
 - ACEI/ARB: احتیاط + پایش K* و کراتینین (بعد از شروع/افزایش ۱–۲ هفته)
 - Amlodipine: بدون تعدیل

ج Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی)

- Abdominal fat (چربی شکمی): کاهش وزن ۵–۱۰ کیلو → کاهش ۵–۲۰ mmHg
- Activity (فعالیت): ۱۵ دقیقه/هفته پیاده‌روی سریع → ۵–۸ mmHg
- Avoid salt (نمک): کمتر از ۵–۶ گرم/روز (حدود یک قاشق چای‌خوری) → ۵–۱۰ mmHg
- Avoid alcohol (الکل): محدود → ۴ mmHg
- Avoid tobacco (سیگار): ترک → کاهش کلی خطر CVD
- طبیعیات (DASH Diet): میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم‌چرب، کم چربی اشباع → ۸–۱۴ mmHg. پتاسیم: افزایش (سیب‌زمینی، موز، سبزی) – مگر در CKD. خواب: ۷–۸ ساعت + بررسی OSA. مدیریت استرس: تکنیک‌های آرام‌سازی، ورزش.

د Surgical / Procedural Management

- استنوز شریان رنل: آنژیو + استنت (در موارد انتخابی)
- دیسکسیون اورت: جراحی عاجل (Type A)
- فتوکروما: آدرنکتومی (بعد از بلوک آلفا)
- فشار مقاوم (Resistant): بررسی سبب ثانویه + Spironolactone

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	ارگان
سکته قلبی (MI)، عدم کفایه قلب (HF)، LVH، فیبریلیشن دهلیزی	قلب
CKD، عدم کفایه مزمن گرده، پروتینوری	گرده
آتورسزم شکمی (AAA)، مرض عروق محیطی (PAD)، آمبولی	عروق
رتینوپاتی، خونریزی زیر مقنی، لوس اتروفی، کوری	چشم
دیسکسیون اورت (Aortic Dissection)	اورت

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پروگنوز: با کنترل فشار به زیر ۱۳۰/۸۰، خطر سکته مغزی ۵۰ فیصد، خطر سکته قلبی ۲۰-۳۰ فیصد کاهش می‌یابد.
- پیگیری:
- هر ۱-۳ ماه تا کنترل فشار
- هر ۶ ماه RFT + الکترولیت‌ها (K⁺)
- هر سال: ECG، لیپید، قند، ادرار، قعر چشم
- HBPM / ABPM برای تأیید کنترل
- هدف پایدار: فشار زیر ۱۳۰/۸۰ (دیابت/CKD) یا زیر ۱۴۰/۹۰ (عمومی)

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. فشار بلند خون = سکته بی‌صدا. مریض درد ندارد؛ آسیب‌ها درد دارند.
۲. یک بار فشار بالا ≠ تشخیص. حداقل دو ملاقات + ABPM/HBPM.
۳. $A + C = ACEI + CCB$ — ترکیب خط اول. ACEI + ARB هرگز با هم.
۴. بحران = فشار بالا + آسیب ارگان. هدف: ۲۵ فیصد کاهش در ساعت اول — نه کامل!
۵. دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲ در ۲۰ دقیقه + بتا بلکر + جراحی.
۶. Nifedipine فوری ممنوع — فقط ACEI/ARB. ER. ACEI/ARB در بارداری ممنوع.
۷. Resistant HTN (سه دوا + فشار بالا) → فکر کن: Spironolactone + سبب ثانویه (استنوز رنل، فئوکروما، کوشینگ، OSA).
۸. پالس بازو و پا را اندازه بگیر — اختلاف = کوشرست اورت.

Red Flags (علائم هشداردهنده — اقدام فوری) ⚠

۱. فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + سرید شدید/انفجاری → سکته مغزی / خونریزی مغزی — CT فوری.
۲. فشار بالا + درد سینه / تنگی نفس حاد → سکته قلبی / ادم ریوی — ECG + اکسیژن + NIC.
۳. فشار بالا + ضعف یک‌طرفه / ناتوانی در گفتار / دوبینی → سکته مغزی — CT فوری.
۴. فشار بالا + درد شکم/کمر شدید و پاره‌شده → دیسکسیون اورت — CTA + جراحی.
۵. فشار بالا + کاهش شدید ادرار / کراتینین بالا → عدم کفایه حاد گرده — ICU.
۶. فشار بالا + تاریب / کوری / سرید → هایپرنتنشن مالتیفورم (Malignant Hypertension) — ICU.
۷. فشار بالا + زه + پروتینوری در حامل → پری‌اکلامپسی / اکلامپسی — سولفات منگنیزیم.
۸. سقوط فشار شدید بعد از شروع دوا → سوپرشن (Hypotension) — قطع دوا + مایع وریدی.

References

- ACC/AHA 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults.
- ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330-332 (Hypertension).
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension).
- Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11.

- “UpToDate: “Hypertensive emergencies” و “Uncomplicated high blood pressure in adults”.
- WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021).

۵ قدم کوچک کنار بستر (Tomorrow's Practice – Atomic Habits)

۱. فردا صبح اولین مریض فشار بلند خون: فشار را در هر دو بازو اندازه بگیر (اختلاف بالای ۱۰ mmHg را یادداشت کن).
۲. پالس بازو و پالس فیملور را در یک مریض فشار بلند خون مقایسه کن.
۳. وزش شکمی (Abdominal Bruit) را در یک مریض فشار بالا با استتسکوپ بشنو.
۴. قعر چشم یک مریض فشار بلند خون را ببین (رتینوپاتی).
۵. ECG یک مریض LVH را بخوان (Voltaic Area بالا).

اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect – پل زنی)

- این فصل چگونه به فصل‌های پیشین گره می‌خورد؟
- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): اندازه‌گیری صحیح فشار + علایم حیاتی – پایه این فصل.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): LVH + S4 + وزش آئورت – نشانه‌های فشار بلند خون.
- فصل ۲ (ECG): LVH در ECG – معیار آسیب ارگان هدف.
- فصل ۳۸ (AKI) و ۳۹ (CKD): آسیب کرده به فشار – پیگیری فشار.
- فصل ۴۲ (الکترولیت‌ها): ACEI/ARB + K⁺ – پایش K⁺.
- فصل ۴۶ (دیابت): هدف فشار در دیابت (زیر ۱۳۰/۸۰) – ترکیب فشار + دیابت.
- فصل ۵۰ (غذوات): سبب ثانویه (کوشینگ، فنوکروما، استنوز رنل) – تشخیص تفریقی.
- فصل ۷۲ (سکته مغزی): فشار + سکته – مدیریت بحران.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Quick Review – 5 Questions)

۱. فشار بلند خون در یک بار ملاقات تشخیص است؟ نه – حداقل دو ملاقات.
۲. بحران هایپرنتینسیو = فشار بالا + چه چیزی؟ آسیب حاد ارگان هدف.
۳. هدف کاهش فشار در ساعت اول بحران؟ حداکثر ۲۵ فیصد – نه کامل.
۴. ACEI + ARB را می‌شود با هم داد؟ هرگز – خطر K⁺ بالا + عدم کفایه گرده.
۵. بهترین دوا چهارم در Resistant HTN؟ PO/OD ۲۵–۵۰ mg Spironolactone.

فصل ۷ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)



{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: قلب یک پمپ دو اتاقه است که باید خون را در دو مدار (ریوی و بدن) بچرخاند. «عدم کفایه قلب» یعنی این پمپ یا ضعیف شده (نمی‌تواند خوب بپمپد – مثل پمپ خراب) یا سفت شده (خون را خوب پر نمی‌کند – مثل یک کیسه لاستیک پیر و سفت). نتیجه هر دو یکی است: خون برمی‌گردد و در ریه (تنگی نفس) و بدن (ادم یا) جمع می‌شود.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

عدم کفایه قلب (Heart Failure) یک سندروم بالینی است – نه یک امراض خاص – که در آن قلب نمی‌تواند خون کافی برای نیاز بافت‌ها با فشار مناسب پمپ کند، و یا برای پرشدن به فشار بالا نیاز دارد. دو مبنای فیزیولوژیک:

- HF با فکشن فرکشن کم (HFrEF): $LVEF \leq 40\%$ – مشکل پمپاژ (سیستولیک)
- HF با فکشن فرکشن محفوظ (HFpEF): $LVEF \geq 50\%$ – مشکل پرشدن (دیاستولیک)

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف ESC 2021: عدم کفایه قلب یک سندروم با اعراض و علائم مشخصه است که بر اثر ناهنجاری ساختاری و یا وظیفوی قلب ایجاد می‌شود.

تصنیف بر اساس (ESC 2021): LVEF

ویژگی	LVEF	نوع
میانہ – مدیریت شبیه HFrEF	41%–49%	HFmrEF (Mildly Reduced)
مشکل انعطاف/پرشدن – چاقی، فشار خون، دیابت	$\geq 50\%$	HFpEF (Preserved)

تصنیف NYHA (کلاس عملکردی):

شرح	کلاس
محدودیت خفیف – فعالیت عادی اعراض‌ساز (تنگی نفس با راهرفت سریع)	II
محدودیت متوسط – فعالیت کمتر از عادی اعراض‌ساز	III
اعراض در استراحت هم – هر فعالیت اضافی بدتر می‌کند	IV

تصنیف Killip (در HF حاد با MI):

- کلاس ۱: بدون رال ریوی
- کلاس ۲: رال قاعده‌ای / S3
- کلاس ۳: ادم ریوی کامل
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: HF = ضعف/سفتی پمپ + پیش‌بار (Preload) و پس‌بار (Afterload) + رنجه-آلدوسترون (RAAS) و سیمپاتیک + بازجذب آب/نمک + احتباس مایعات + تنگی نفس و ادم + HF بدتر + حلقه فاصله‌دار

۱. قدم ۱ – ضربه اولیه: MI، فشار بلند خون مزمن، درمهای (Valvular)، کاردیومیوپاتی (الکلی، ویری، کیموترپی) → کاهش Contractility یا افزایش سفتی.
 ۲. قدم ۲ – کاهش Cardiac Output: مغز و گرده خون‌رسانی کم می‌گیرند → فعال‌شدن RAAS + سیستم سیمپاتیک (پاسخ جبران‌دهنده).
 ۳. قدم ۳ – بازجذب سدیم و آب: آلدوسترون و ADH → گرده نمک و آب نگه می‌دارد → حجم خون بالا می‌رود → پیش‌بار بالا.
 ۴. قدم ۴ – بازناشوندگی (Remodeling): قلب بزرگ و بیضی می‌شود، عضله با فیبروز جایگزین می‌شود → HF بدتر.
 ۵. قدم ۵ – احتقان وریدی (Venous Congestion): فشار رگ‌ها بالا → رال ریوی (چپ) + ادم پا (راست).
 ۶. قدم ۶ – عدم کفایه ارگان‌های دور: «کاردیورنل سیندر» – گرده و کبد کم خون‌رسانی می‌شوند.
- تصویر: «پمپ ضعیف» → بدن فکر می‌کند آب کم است → آب جمع می‌کند → ریه خیس می‌شود → پمپ بیشتر خسته می‌شود» – این حلقه فاصله‌دار است که تداوی را می‌شکند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

دسته	امراض
درمه‌ای	استنوز آئورت، ناکافی آئورت، ناکافی میترال، استنوز میترال
کاردیومیوپاتی	دیلاتی (الکی، ویری، کیموترپی، جنی)، هایپرتروفیک (HCM)
ریوی	COPD، امبولی ریوی مزمن (HF راست)
ریتمی	تاکیکاردی مزمن (Tachycardia-induced)، فیبری لیشن دهلیزی
متابولیک	دیابت، هایپرتیرئیدی / هایپوتیرئیدی، کمبود تیائین (Beriberi)
هاستیک	کهموزیس مزمن (High-output) – در مراحل پیشرفته
فکتورهای مساعد	افزایش سن، چاقی، آپنه خواب، استرس، انتان، تاکی‌آریتمی، NSAID / کورتیکواستروئید، حاملگی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تنگی نفس (Dyspnea): با فعالیت → در استراحت (Progressive)
 - Orthopnea: تنگی نفس در خوابیدن مسطح – با بالشت بالا بهتر
 - PND (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea): بیدار شدن در شب با تنگی نفس شدید
 - خستگی و ضعف، کم‌اشتها، تنگی نفس با تعریق
 - افزایش وزن سریع (احتباس مایعات – ۲ کیلو در ۳ روز = هشدار!)
- علائم (چپ + راست):

سیستم	علامت
چپ	S3 Gallop (داکتر باید بشنود – «موسیقی عدم کفایه»)
راست	تاکیکاردی، JVP بالا، R wave بزرگ در V1-V2
راست	ادم پا (Pitting)، جگر بزرگ (Hepatomegaly)
هر دو	وزش ناکافی میترال (چپ) یا تریکوسپید (راست)
هر دو	کاهش پالس، هیپوتنشن (مرحله پیشرفته)

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه HF:

- ☐ علائم حیاتی: تاکیکاردی، تاکی‌پنه، SpO2
- ☐ JVP: ارتفاع (بالای ۵ سانتی = بالا)، موج‌ها
- ☐ ریه: رال قاعده‌ای (چپ)، کریپلوس
- ☐ قلب: ریتم (فیبری لیشن؟)، S3 / S4، وزش درمه‌ای
- ☐ بطن: جگر بزرگ و دردناک، Ascites
- ☐ پاها: ادم Pitting (درجه ۱-۴)
- ☐ وزن: مقایسه با وزن قبل (احتباس)
- ☐ SpO2: زیر ۹۲ = نیاز به اکسیژن

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
امبولی ریوی	تنگی نفس حاد، درد قفسه سینه، D-dimer، CTPA
درمهای (Valvular)	وزش درمهای، Echo – سبب اصلی HF
پریکاردیت	درد قفسه سینه با حالت، راکتشن – Echo (Effusion)
آئمی شدید	تنگی نفس + رنگ پریدگی + CBC
هایپرتیرئیدی	تاکیکاردی + وزش تایراید + TSH
حاملگی	PND + JVP – بعد از هفته ۲۰
نفروتیک سندروم	پروتینوری + ادم – بدون Rales

۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (هر مریض HF جدید):
- BNP / NT-proBNP: BNP > ۱۰ pg/mL یا NT-proBNP > ۳۰۰ pg/mL (سن-مصحوب) → HF محتمل
 - ۱۲ ECG لید: ریتم (فیبری لیشن؟)، Q waves، LVH، (MI سابق)
 - CBC: آئمی (سبب HF)
 - RFT + الکترولیتها: کراتینین، *K (قبل از ACEI/MRA)
 - LFT + بیلیروبین: کبد چپ (Congestive Hepatopathy)
 - TSH: هایپو/هایپرتیرئیدی
 - قند خون / HbA1c: دیابت
 - رادیوگرافی قفسه سینه (CXR): Pulmonary Edema، Kerley B lines، Cardiomegaly (CTR > ۰.۵)
 - LVEF: Echo (TTE) (معیار اصلی)، پرشدن (Diastolic)، درمهای، فشار شریان ریوی
- پیشرفته / خاص:
- Cardiac MRI: کاردیومیوپاتی، ویروس، امبلاسیس
 - Stress test / CAG: CAD (در HFrEF با سابقه)
 - SpO2 / ABG: در HF حاد
 - Echo تکرار: بعد از ۳-۶ ماه (تغییر LVEF)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص (ESC 2021) HF – هر دو:
۱. اعراض و/یا علائم عدم کفایه قلب (تنگی نفس، خستگی، ادم)
 ۲. شواهد عینی ناهنجاری قلبی (LVEF: Echo کم و/یا پرشدن نامعاف + BNP/NT-proBNP بالا + CXR)
- تشخیص HF: LVEF ≤ ۴۰% + HFpEF: LVEF ≥ ۵۰% + اعراض/علائم HF + شواهد پرشدن نامعاف (Echo)
- BNP / diastolic بالا / همزمانی: چاقی، فشار خون، دیابت، سن بالا)

۱۰. Management (تداوی)

الف) (Decompensated / HF حاد) Emergency & General Care

الگوریتم HF حاد:

۱. قدم ۱ – ABC + وضعیت نشسته (بالشت ۳۰-۴۵ درجه) + اکسیژن اگر $SpO_2 < 92\%$
۲. قدم ۲ – تشخیص: ECG (ریتم/MI)، K، RFT، CXR، BNP*
۳. قدم ۳ – دیورتیک وریدی (Furosemide):
- اگر بدون دیورتیک فمی قبلی: Furosemide ۴۰ mg IV
- اگر با دیورتیک فمی قبلی: دو برابر دوز روزانه فمی، IV
- اگر پاسخ کم (۲ ساعت): افزایش دوز یا دو دیورتیک (Furosemide + Bumetanide)
۴. قدم ۴ – Vasodilator (اگر BP سیستولیک < ۱۰۰): Nitroglycerin IV ۱۰-۲۰ mcg/min شروع، افزایش هر ۵ دقیقه تا ۲۰۰ mcg/min
- Nitroprusside ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr یا

۵. قدم ۵ – دردهٔ سینه / MI: مدیریت ACS (فصل ۸)
۶. قدم ۶ – فیبری لیشن تاکی: Cardioversion → اگر ناپایدار – Rate control (Digoxin IV / Amiodarone IV)
۷. قدم ۷ – شوک کاردیوژنیک: Vasopressor + Inotrope (Dobutamine / Milrinone) + مکانیکی (IABP / ECMO)
۸. قدم ۸ – تنفس: NIV (CPAP/BiPAP) اگر تاکی پنه / ادم ریوی – اگر ناکافی → Intubation
۹. قدم ۹ – پایش: ادرار ساعتی، K^+ ، Cr ، وزن روزانه

ب) Pharmacotherapy – چهار ستون (ESC 2021 / AHA 2022) HFrEF

فرمول ۴ ستون: (SGLT2i) + (MRA) + (Betablocker) + (ARNI/ACEI/ARB) = HFrEF – همزمان، دوز کم شروع، تدریجی افزایش
ستون ۱ – RAAS Blocker (ARNI > ACEI/ARB):

دوا	دوز شروع	افزایش	دوز حداکثر	راه/تکرار	یادداشت
Enalapril (جایگزین)	mg ۲.۵	۲ هفته	mg BID ۲۰	PO / BID	وزش خشک
Ramipril	mg ۲.۵	۲ هفته	mg OD ۱۰	PO / OD	
Lisinopril	mg ۵	۲ هفته	mg OD ۴۰	PO / OD	
Losartan (ARB)	mg ۵۰	۲ هفته	mg OD ۱۰۰	PO / OD	اگر وزش از ACEI

ستون ۲ – Betablocker (سه دوا اثبات شده):

دوا	دوز شروع	دوز حداکثر	راه/تکرار
Bisoprolol	mg ۱.۲۵	mg ۱۰	PO / OD
Metoprolol Succinate	mg ۱۲.۵	mg ۲۰۰	PO / OD

{ Betablocker را فقط در HF پایدار (بدون احتباس حاد) شروع کن – دوز کم، هر ۲ هفته دو برابر کن، تا دوز هدف یا حداکثر تحمل. }

ستون ۳ – MRA (Mineralocorticoid Receptor Antagonist):

دوا	دوز	راه/تکرار	کنتراندیکاسیون
Eplerenone (بعد از MI)	mg ۵۰-۲۵	PO / OD	$K^+ > ۵.۵$ ، $eGFR < ۳۰$

ستون ۴ – SGLT2 Inhibitor (از ۲۰۲۰ – تمام HFrEF، با یا بدون دیابت):

دوا	دوز	راه/تکرار	یادداشت
Empagliflozin	mg ۱۰	PO / OD	$eGFR > ۲۰$

دوای کمکی (Adjunctive):

دوا	دوز	اندیکاسیون
Hydralazine + ISDN	mg ۱ ISDN + mg ۲۵ Hyd / روز	سیاه پوستان / ACEI+ARB کنتراندیکه
Ivabradine	mg ۷ → ۵	$HR > ۷۰$ – PO / BID + سینوس ریتم + HFrEF
Vericiguat	mg ۱۰ → ۲.۵	PO / OD – بعد از Decompensation

Dosing در عدم کفایه گرده:

- ACEI/ARB: $eGFR < ۳۰$ – احتیاط + پایش K^+/Cr
- Spironolactone: $eGFR < ۳۰$ – ممنوع
- Furosemide: $eGFR < ۳۰$ – دوز بالاتر (۸۰-۱۶۰ mg)
- SGLT2i: $eGFR < ۲۰-۲۵$ – شروع نکن

ج) Non-pharmacological Management

- محدودیت نمک: کمتر از ۵-۶ گرم/روز
- محدودیت مایعات: ۱.۵-۲ لیتر/روز (در احتباس مقاوم)
- وزن روزانه: افزایش ۲ کیلو در ۳ روز → تماس با داکتر
- فعالیت: ورزش تدریجی (Cardiac Rehabilitation) – ۱۵ دقیقه/هفته
- ترک سیگار + الکلی: ضروری
- واکسیناسیون: آنفلوانزا + پنوموکوک (هر سال)
- چربی/قند/دیابت: کنترل
- دواهای خطرناک را قطع کن: NSAID، کورتیکواستروئید، Verapamil/Diltiazem (در HFrEF)

د) Surgical / Procedural Management

- CABG / PCI: در HFrEF + ایسکمی

- درمه پلاستی / تعویض (TAVI/SAVR): درمه ای (استنوز/ناکافی)
- CRT (Cardiac Resynchronization Therapy): $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \text{ ms}$
- ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator): $LVEF \leq 35\% + NYHA \text{ II-III}$ + بعد از ۳ ماه تداوی
- پیوند قلب (Transplant): $NYHA \text{ IV}$ مقاوم – معیارهای خاص

۱۱. Complications (اختلالات)

- ریوی: ادم ریوی، پنومونی، آمبولی ریوی (DVT)
- عروقی: سکته قلبی، سکته مغزی (فیبری لیشن)
- گرده: کاردیورنل سیندر، AKI
- کبد: کنگستیف هپاتوپاتی، Ascites
- ریتمی: فیبری لیشن، تاقیکاردی، VF
- نورولوژیک: دماس وازو، Delirium
- ترومبوتیک: DVT / PE (بسیار شایع در HF)
- پیشرفته: شوک کاردیوژنیک، مرگ ناگهانی (Sudden Cardiac Death)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: ۵۰ فیصد مرگ و میر ۵ ساله (بدون تداوی بهینه). با ۴ ستون CRT/ICD +، پروگنوز به طور قابل توجهی بهتر.
- پیگیری:
- هر ۲-۴ هفته تا پایدار
- $K^+ + Cr: 1-2$ هفته بعد از هر تغییر دوز (ACEI/MRA/SGLT2i)
- Echo: ۳-۶ ماه اول، سپس سالانه
- BNP/NT-proBNP: پیگیری روند
- آموزش: وزن روزانه، محدودیت مایعات/نمک، علامات هشدار

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. HF = سندروم، نه امراض. $LVEF$ را بدان: $HFpEF = 40 \geq$ ، $HFrEF = 40 <$.
۲. S3 Gallop = موسیقی عدم کفایه قلب. اگر S3 شنیدی، HF را جدی بگیر.
۳. PND (بیدار شدن شبانه با تنگی نفس) = نشانه کلاسیک HF چپ.
۴. ۴ ستون $ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i$ - $HFrEF$: همه ۴ تا، دوز کم شروع.
۵. Betablocker را در احتباس حاد شروع نکن - اول احتباس را بشکن، بعد Betablocker.
۶. Furosemide IV = دو برابر دوز فمی روزانه (اگر قبلاً فمی بوده).
۷. $K^+ + Cr$ را ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر ACEI/MRA چک کن.
۸. $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \rightarrow CRT$. $LVEF \leq 35\% + 3$. ICD $\rightarrow$ ماه تداوی

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. تنگی نفس حاد + HF $\rightarrow$ Orthopnea + Rales / ادم ریوی - اکسیژن + Furosemide IV.
۲. $SpO_2 < 90\%$ + تاکی پنه $\rightarrow$ NIV (CPAP/BiPAP) $\rightarrow$ اگر ناکافی Intubation.
۳. BP سیستولیک > 90 + سردی/تعریق + کاهش ادرار $\rightarrow$ شوک کاردیوژنیک - Inotrope + ICU.
۴. درد سینه + ECG جدید (ST elevation) $\rightarrow$ ACS هم زمان - مدیریت MI.
۵. فیبری لیشن تاکی ($HR > 120$) + ناپایدار $\rightarrow$ Cardioversion فوری.
۶. افزایش وزن ۲+ کیلو در ۳ روز $\rightarrow$ احتباس - D والوپ افزایش + تماس داکتر.
۷. $K^+ > 5.5$ بعد از ACEI/MRA $\rightarrow$ قطع/تعدیل ECG (رنگ های T).

References

- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

- AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140–142
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- "Acute decompensated heart failure" و "UpToDate: "HFrEF: Treatment
- DAPA-HF / EMPEROR-Heart (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. S3 را در یک مریض HF بشنو (بعد از S2، نرم و کمفام).
۲. JVP یک مریض HF را اندازه بگیر (بالای ۵ سانتی = بالا).
۳. BNP/NT-proBNP یک مریض تنگی نفس را چک کن و تفسیر کن.
۴. Echo یک مریض HFrEF را ببین (LVEF + پرشدن + درمه‌ها).
۵. CXR یک مریض HF را بخوان (CTR + Rales + Kerley B).

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): JVP + ادم + علایم حیاتی – پایۀ معاینه HF.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3/S4 + وزش درمه‌ای – تشخیص HF.
- فصل ۲ (ECG): فیبری‌لیشن + Q waves + LVH – سبب و پیگیری.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = شایع‌ترین سبب HF.
- فصل ۸ (ACS): MI = شایع‌ترین سبب ACS + HFrEF هم‌زمان.
- فصل ۹ (درمه‌ها): درمه‌ای = سبب HF – Echo.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + Rate control + HF – آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): DVT/PE = اختلاط شایع HF.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. $LVEF = HFrEF$ چند؟ $\geq 40\%$.
۲. چهار ستون $HFrEF$ ؟ ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i.
۳. Betablocker را در احتباس حاد شروع می‌کنی؟ نه – اول احتباس.
۴. Furosemide IV در مریض با Furosemide فمی قبلی؟ دو برابر دوز روزانه فمی.
۵. $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130$ → چه دسایسی؟ CRT.

فصل ۸ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (Acute Coronary Syndrome / Myocardial Infarction)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: عروق قلب مثل لوله‌های آبی هستند که چربی (پلاک) در دیواره آن‌ها رسوب کرده. یک روز، یک تکه از این رسوب می‌شکند و خون روی آن لخته می‌شود (ترومب) – لوله کاملاً بسته می‌شود و عضله قلب از آن طرف «بی‌آب» می‌ماند و می‌میرد. هر دقیقه تأخیر = بیشتر عضله مرده. پس این مریض زمان است – Time is Muscle.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سندروم کرونری حاد (ACS) طیفی است که شامل سه شکل می‌شود:

۱. سکته قلبی با بالا رفتن خط ست (STEMI): انسداد کامل شریان → آسیب ترانس‌مولاری (Transmural) – عاجل‌ترین
۲. سکته قلبی بدون بالا رفتن خط ست (NSTEMI): انسداد ناقص/گذرا → آسیب ساب‌اندوکاردیال (Subendocardial)
۳. آنژین ناپایدار (Unstable Angina): ایسکمی بدون مرگ سلولی (تروپونین منفی)

فرمول: ACS = پلاک شکسته + ترومب = انسداد عروق → ایسکمی/نفارکتوس – مداوی = باز کردن عروق + جلوگیری از ترومب بیشتر

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: سندروم کرونری حاد یک سندروم بالینی است که بر اثر کاهش ناگهانی خون‌رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شود.

نوع	ST	تروپونین	مکانیزم
NSTEMI	بدون (یا ST depression)	↑	انسداد ناقص (50-90٪)
Unstable Angina	بدون	نرمال	انسداد گذرا

طبقه‌بندی بر اساس فاصله زمانی (Killip برای سکته):

- کلاس ۱: بدون علائم عدم کفایه قلب
- کلاس ۲: عدم کفایه خفیف (رال / S3)
- کلاس ۳: عدم کفایه شدید (ادم ریوی)
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step

فرمول: پلاک شکننده (Vulnerable Plaque) ← شکستن (Rupture) ← ترومب (Thrombus) ← انسداد ← ایسکمی (Ischemia) ← نفارکتوس (Infarction)

۱. قدم ۱ – تشکیل پلاک: اتروسکلروز (Atherosclerosis) – لیپید + کلسترول + ماکروفاژ در دیواره شریان.
 ۲. قدم ۲ – پلاک شکننده (Vulnerable Plaque): پلاک بزرگ با هسته لیپیدی بزرگ و کلاهک نازک → مستعد شکستن.
 ۳. قدم ۳ – شکستن پلاک: استرس، فشار خون بالا، سیگار → پلاک می‌شکند → محتویات (تکسیبی‌لین) با خون تماس می‌گیرند.
 ۴. قدم ۴ – ترومب: پلاکت‌ها چسبیده و ترومب می‌سازند (ترومب سفید + قرمز) → انسداد کامل یا ناقص.
 ۵. قدم ۵ – ایسکمی: عضله قلب بدون اکسیژن می‌ماند → آسیب سلولی → مرگ (نفارکتوس).
 ۶. قدم ۶ – نشانه‌های آنژین: تروپونین (Troponin I/T) به خون نشت می‌کند (معیار تشخیصی).
 ۷. قدم ۷ – بازسازی/بازنوزیع: رگ‌های جدید (کالاجن) جایگزین می‌شوند → اسکار (Scar) → تغییر شکل (Remodeling) → عدم کفایه قلب.
- تصویر: «پلاک = رسوب لوله آب، شکستن = ترک، ترومب = لخته، انسداد = بسته شدن لوله، نفارکتوس = مرگ بافت پشت لوله.»

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

خطر	فکتور
۲-۴ برابر خطر - اتروسکلروز شتابان	دیابت (Diabetes)
۲-۴ برابر - ایسکمی + ترومب	سیگار (Smoking)
LDL بالا - تشکیل پلاک	هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia)
اتروسکلروز + التهاب	چاقی / چاقی شکمی
مردان < ۴۵، زنان < ۵۵	سن / جنس
MI در مرد > ۵۵ / زن > ۶۵	سابقه خاندان (Family History)
اتروسکلروز	کم تحرکی
فعالی شدن سیمپاتیک	استرس مزمن
فشار خون + لیپید	الکلی زیاد
خطر تکرار	سابقه ACS / CAD
کم رسانی اکسیژن	آنمی مزمن

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- درد قفسه سینه (Chest Pain): فشار/سنگینی/سوزش، پشت جناغ استرن، انتشار به بازوی چپ / فک / شانه / کمر. ۱۵-۶۰ دقیقه طولانی (نه چند ثانیه). با فعالیت بدتر، با استراحت/نیتروگلیسرین بهتر.
- تنگی نفس (Dyspnea) - اغلب همزمان با درد
- تعریق سرد (Cold Sweat)
- تهوع / استفراغ (Nausea/Vomiting)
- سرگیجه / سنینکوپ (Dizziness/Syncope)
- ترس از مرگ (Sense of Doom)
- در زنان / مسنان / دیابت: اعراض «بی حرفه‌ای» - تنگی نفس، ضعف، درد شکم، تهوع - بدون درد سینه (Silent MI)

علائم:

- تعریق سرد + بی‌قراری + رنگ‌پریدگی (کلاسیک)
- تاقیکاردی (رایج‌ترین) یا برادی‌کاردی (در inferior MI)
- فشار خون بالا (درد) یا پایین (shock / RV infarction)
- S3 Gallop (عدم کفایه حاد)
- RAL / ادم ریوی (Killip III)
- کاهش پالس / سردی دست‌وپا (Killip IV)
- ECG: ST elevation (STEMI) / ST depression / T inversion / Q waves

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه ACS:

- ☐ علائم حیاتی: BP (هر دو بازو)، HR، RR، SpO2، دما
- ☐ درد سینه: ویژگی (SOCRATES: Site, Onset, Character, Radiation, Associated, Time)
- ☐ قلب: ریتم، S3/S4، وزش نو (MR / VSD)
- ☐ ریه: Rales، SpO2
- ☐ JVP + ادم پا (RV infarction در inferior MI)
- ☐ ECG 12 لید در ۱۰ دقیقه اول (معیار طلایی)
- ☐ پالس محیطی (دیسکسیون؟)
- ☐ معاینه عصبی (سکته مغزی همزمان؟)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
امبولی ریوی (PE)	تنگی نفس حاد، DVT، D-dimer، CTPA
پریکاردیت	درد با حالت (بهتر در قوس)، فریکشن راب، ST elevation گسترده + PR depression
آپنه معده (GERD/Spasm)	سوزش، با غذا، نیتروگلیسرین اثر کم، ECG نرمال
کوستوکندریت	درد موضعی، با لمس بدتر، بدون ECG تغییر
سینه‌نشی (Pneumothorax)	تنگی نفس + کاهش صدای زنگ، CXR
آنژیوکینتیک (Takotsubo)	بعد از استرس، CAG، ECG ST elevation بدون انسداد
سکته مغزی (Stroke)	ضعف یک‌طرفه، CT مغز

۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (همه Mریضان ACS):
- ECG 12 لید: در ۱۰ دقیقه اول – ST elevation / depression، T inversion، Q waves
 - Troponin (یا T): حساس / سریع (High-sensitivity) – در ۱، ۳، ۰ ساعت
 - CBC: آئمی / انتان
 - RFT + الکترولیت‌ها: قبل از دواها
 - LFT: کبد چپ
 - Coagulation (PT/INR/aPTT): قبل از آنتی‌کواگولاسیون
 - CXR: عدم کفایه قلب، دیسکسیون
 - لیپید + قند + HbA1c: فکتورهای خطر
 - BNP/NT-proBNP: عدم کفایه قلب هم‌زمان
 - پیشرفته / ویژه:
 - ECG تکرار: هر ۱۵-۳۰ دقیقه (تغییر ST)
 - Echo (TTE): دیواره‌های متحرک (LVEF، RV، Wall Motion Abnormality)
 - Cath / CAG (Coronary Angiography): معیار طلایی – در STEMI (Primary PCI) / NSTEMI (Early Invasive)
 - CT Angiography: در شبهه دیسکسیون / PE
 - D-dimer: PE

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص STEMI (ESC 2023):
- ST elevation در ۲ لید مجاور (J-point):
 - V2-V3: ≥ 2 mm در مردان ≥ 40 سال، ≥ 2.5 mm در مردان > 40 سال، ≥ 1.5 mm در زنان (→ فصل ۲)
 - سایر لیدها: ≥ 1 mm
 - LBBB جدید (با اعراض)
 - تروپونین بالا (اگر ECG مبهم)
 - تشخیص NSTEMI:
 - Troponin بالا (≥ 99 th percentile) + بدون ST elevation + اعراض ایسکمیک
 - GRACE Score برای طبقه‌بندی خطر (Early Invasive vs Conservative)

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- الگوریتم STEMI (Time-Critical):
۱. قدم ۱ – ECG در ۱۰ دقیقه + تشخیص STEMI
 ۲. قدم ۲ – Antiplatelet + Anticoagulant فوری (زیر)
 ۳. قدم ۳ – Reperfusion

- Primary PCI: اگر در ۹۰ دقیقه (FMC-to-Device) ممکن است → PCI
- Fibrinolysis: اگر PCI ممکن نیست → Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه (Door-to-Needle)
- اگر هیچ‌کدام ممکن نیست → انتقال به مرکز PCI
- ۴. قدم ۴ – بعد از PCI + CAG + Reperfusion
- ۵. قدم ۵ – Secondary Prevention: Statin + ACEI + Betablocker + دواهای ضد پلاکت
الگوریتم NSTEMI:
- ۱. ECG + Troponin (در ۰ و ۱/۳ ساعت)
- ۲. Antiplatelet + Anticoagulant (Clopidogrel/Ticagrelor + Heparin/Enoxaparin)
- ۳. GRACE Score:
- High Risk (ST) / GRACE > 140 / تغییر / arrhythmia / (HF / CAG+PCI) Early Invasive → (در ۲۴ ساعت)
- Low Risk → تست ورزش / Medical Management / CTA

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

Antiplatelet (هر دو نوع ACS):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Clopidogrel	۳۰۰ mg (بدون PCI) / ۶۰۰ mg (PCI)	PO	یکبار	سپس ۷۵ mg PO/OD – ۱۲ ماه (ACS)
Ticagrelor	۱۸۰ mg	PO	یکبار	سپس ۹۰ mg PO/BID – ۱۲ ماه (ACS در) Ticagrelor > Clopidogrel
Prasugrel	۶۰ mg	PO	یکبار	سپس ۱۰ mg PO/OD – ۱۲ ماه (فقط PCI، سنین > ۷۵، بدون سکت سابق)

Anticoagulant

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Enoxaparin	۱ mg/kg	SC	هر ۱۲ ساعت	سنین < ۷۵ / ۰.۷۵ mg/kg/12h → CrCl < ۳۰
Fondaparinux	۲.۵ mg	SC	روزانه	فقط NSTEMI – در PCI از UFH استفاده کن
Bivalirudin	۰.۷۵ mg/kg/hr + ۱.۷۵ mg/kg bolus	IV	Continous	در PCI – جایگزین Heparin

Antianginal / Vasodilator

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Nitroglycerin IV	۵–۲۰۰ mcg/min	IV (پمپ)	Continous	هدف: بدون درد، BP سیستولیک < ۹۰
Morphine	۲–۴ mg	IV	هر ۵–۱۵ دقیقه	فقط اگر درد مقاوم – احتیاط (hypotension)

STEMI / NSTEMI (بدون HF / shock / bradycardia): Betablocker

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Metoprolol IV	۵ × ۳ mg	IV	هر ۲–۵ دقیقه	فقط اگر PO ممکن نیست – max ۱۵ mg
Atenolol	۲۵–۵۰ mg	PO	یکبار	جایگزین

△ Betablocker را در HF حاد / heart block / bradycardia / shock شروع نکن. { Statins (همه ACS، هر LDL):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت
Rosuvastatin	۲۰–۴۰ mg	PO	OD	جایگزین

:ACEI / ARB (LVEF < ۴۰٪ / HTN / DM / anterior MI)

دوا	دوز شروع	راه	تکرار	یادداشت
Lisinopril	۵ mg	PO	OD	سپس ۱۰–۲۰ mg OD

Fibrinolytic (STEMI بدون PCI):

دوا	دوز	راه	مدت	یادداشت
Alteplase (tPA)	۱۵ mg (max) → ۰.۷۵ mg/kg bolus → ۰.۵ mg/kg در ۳۰ دقیقه (max ۳۵ mg) در ۶۰ دقیقه	IV	Continous	مجموع ۱۰۰ mg
Streptokinase (SK)	۱.۵ million U در ۱۰۰–۲۵۰ mL NS	IV infusion	۶۰ دقیقه	اگر SK قبلاً استفاده شده (> ۶ ماه) → ممنوع (allergy)

کنتراندیکاسیون‌های مطلق Fibrinolysis:

- خونریزی مغزی سابق (ICHD)
- سکته مغزی ischemic در ۳ ماه اخیر
- شک به دیسکسیون اورت
- خونریزی فعال / اختلال انعقادی
- تروما سر/صورت شدید در ۳ ماه اخیر
- تومور مغزی / آنوریسم / AVM

ج Non-pharmacological Management

- استراحت مطلق در فاز حاد
- اکسیژن فقط اگر $SpO_2 < 90\%$
- کنترل درد (Morphine)
- پایش ECG (Monitor)
- رژیم کم‌نمک / کم‌چربی
- ترک سیگار (مهم‌ترین فکتور قابل تغییر)
- Cardiac Rehabilitation (بعد از ترخیص)
- واکسیناسیون آنفلوانزا (هر سال)

د Surgical / Procedural Management

- Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention): بیلینگ + استنت (DES) – معیار طلایی STEMI
- CABG (Coronary Artery Bypass Graft): سه‌شانه‌ای / Cx / چپ / LAD – اگر PCI ممکن نیست
- IABP / ECMO / Impella: در shock / مکانیک al complication
- Joint / Valve Repair: در VSD / MR حاد

۱۱. Complications (اختلالات)

زمان	اختلال
۴-۱ روز	Heart Failure (Killip III/IV)
۷-۱ روز	Cardiogenic Shock
۷۲-۱ ساعت	Arrhythmia (VF / VT / SVT / Brady)
۷-۳ روز	Mechanical Complication (VSD / Papillary Muscle Rupture / Free Wall Rupture)
بعد از استراحت مطلق	DVT / PE
۸-۲ هفته	Dressler Syndrome (پریکاردیت بعد از MI)
بعد از ترخیص	Depression / PTSD
۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG	Renal Failure (Contrast)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: با PCI سریع + Secondary Prevention، مرگ‌ومیر ۳۰ روزه $> 5\%$. بدون تداوی، مرگ‌ومیر بالا.
- پیگیری:
- ترخیص: ۵-۳ روز (STEMI) / ۲-۴ روز (NSTEMI)
- ECG + Echo: قبل از ترخیص + ۶ هفته بعد
- Lipid + LFT: ۴ هفته بعد از Statin
- RFT: ۴۸-۷۲ ساعت بعد از CAG
- Stress Test: ۶-۸ هفته بعد (اگر Conservative)
- کنترل فشار / قند / لیپید: هر ۳ ماه
- Secondary Prevention: Aspirin + P2Y12 (۱۲ ماه) + ACEI + Betablocker + Statin + ترک سیگار + ورزش

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. Time is Muscle. هر ۳۰ دقیقه تأخیر در Reperfusion = بیشتر عضله مرده.

۲. STEMI = PCI در ۹۰ دقیقه / Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه.
۳. Aspirin ۳۰۰ mg chewed – اولین دوا که مریض می‌خورد (حتی قبل از ECG).
۴. Ticagrelor ۱۸۰ mg → ۹۰ mg BID از Clopidogrel بهتر در ACS.
۵. Nitroglycerin را در RV infarction (inferior MI + JVP) بالا نده – hypotension.
۶. Betablocker را در HF / shock / bradycardia نده.
۷. Troponin 0 و 1 ساعت – اگر بالاتر از NSTEMI = 99th percentile.
۸. دیسکسیون اورت = درد پاره‌شده + اختلاف فشار بازوها – Fibrinolytic ممنوع (مردن!).

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. درد قفسه سینه + STEMI – PCI / Fibrinolytic → ST elevation فوری.
۲. درد قفسه سینه + BP پایین + JVP بالا + رال → Nitroglycerin – RV infarction ممنوع + مایع وریدی.
۳. درد قفسه سینه + اختلاف فشار بازوها / پALS نامتقارن → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
۴. Defibrillation → VF / VT فوری (CPR).
۵. سینکوپ + تاکی‌کاردی / برادی‌کاردی → Monitor + Atropine / Pace – Arrhythmia.
۶. Rales + BP پایین → Inotrope + ICU + IABP – Cardiogenic Shock.
۷. درد جدید + وزش نو (MR / VSD) → Echo – Mechanical Complication + جراحی.

References

- ESC 2023 Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes
- AHA/ACC 2014 (2023 Update) STEMI / NSTEMI Guidelines
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23
- "NSTEMI: Initial Management" و "UpToDate: STEMI: Treatment"
- PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

قدم کوچک کنار بستر

۱. ECG 12 لید یک مریض درد سینه را در ۱۰ دقیقه اول بگیر و بخوان.
۲. ST elevation را در ۲ لید مجاور بشناس (V2-V3 / I-aVL / V1-V6).
۳. Troponin یک مریض NSTEMI را بخوان (99th percentile).
۴. JVP + Rales + BP را در یک مریض MI معاینه کن (Killip class).
۵. Aspirin ۳۰۰ mg را به یک مریض ACS بده و زمان‌بندی را یادداشت کن.

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): علایم حیاتی + SpO2 – پایۀ مدیریت ACS.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3 + وزش MR – اختلاط MI.
- فصل ۲ (ECG): ST elevation / depression – معیار تشخیص ACS.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = فکتور خطر #۱.
- فصل ۷ (HF): MI = شایع‌ترین سبب HF – Killip class.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + Rate control – ACS + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۴۶ (دیابت): دیابت = فکتور خطر + اعراض «بی‌حرفه‌ای» (Silent MI).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. STEMI = Reperfusion در چند دقیقه؟ ۳۰ / Fibrinolytic / ۹۰ PCI دقیقه.
۲. اولین دوا ACS؟ Aspirin ۳۰۰ mg chewed.
۳. Ticagrelor دوز شروع + ادامه؟ ۱۲۰ ۱۸۰ mg BID → ۹۰ mg ماه.

۴. Nitroglycerin را در چه MI ندهی؟ RV infarction (inferior + JVP بالا).
۵. کنترااندیکاسیون مطلق Fibrinolytic؟ خونریزی مغزی سابق / سکته مغزی ۳ ماه اخیر / دیسکسیون.